

Monograf

**MUROTAL DAN HYPNOBIRTHING
TERAPAN DALAM ASUHAN
KEPERAWATAN SEBAGAI PENGURANG
NYERI MELAHIRKAN**

Hesti Ratna Sari



Buku Monograf
Murotal dan *Hypnobirthing* Terapan
Dalam Asuhan Keperawatan
Sebagai Pengurang Nyeri Melahirkan

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Monograf
Murotal dan *Hypnobirthing* Terapan
Dalam Asuhan Keperawatan
Sebagai Pengurang Nyeri Melahirkan

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-96049-5-6
Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul *"Murrotal dan Hypnobirthing Terapan dalam Asuhan Keperawatan Sebagai Pengurang Nyeri Melahirkan"*. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kepedulian terhadap kenyamanan ibu saat proses persalinan, khususnya dalam konteks pendekatan keperawatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan spiritual.

Buku ini menyajikan kombinasi antara pendekatan ilmiah dan spiritual melalui intervensi *hypnobirthing* dan terapi *murrotal* yang terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri persalinan. Diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam praktik keperawatan maternitas, serta menjadi panduan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan yang lebih holistik, manusiawi, dan berbasis nilai keislaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia.

Juni 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 <i>Hypnobirthing</i> dan Murrotal	6
A. Hypnobirthing.....	6
B. Murrotal.....	12
C. Aplikasi Asuhan Keperawatan menurut Katharine Kolcaba	15
BAB 3 Hypnobirthing dan Murrotal Sebagai Pengurang Nyeri Melahirkan Pada Ibu Intranatal	18
A. Ruang Lingkup Intranatal	18
B. Konsep yang Mempengaruhi Persalinan	22
C. Proses Persalinan	25
D. Manajemen Nyeri Melahirkan.....	28
BAB 4 Penerapan Hypnobirthing sebagai Teknik Relaksasi untuk Ibu Intranatal.....	39
A. Karakteristik Ibu Intranatal	39
B. Terapan Murrotal pada Ibu Intranatal	42
C. Terapan Hypnobirthing pada Ibu Intranatal	46
D. Integrasi Murrotal dan Hypnobirthing dalam Mengurangi Nyeri Melahirkan Pada Ibu Intranatal	49
BAB 5 Penutup.....	59
Daftar Pustaka	60
Glosarium	67
Profil Penulis	68

BAB 1

Pendahuluan

Melahirkan merupakan sebuah pengalaman subjektif dan isu multidimensi, dimana setiap perempuan memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam melewati pengalaman tersebut. melahirkan itu sendiri didefinisikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi dari dalam rahim menuju jalan lahir, yang diawali dengan timbulnya kontraksi uterus yang menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks serta iskemia uterus, sehingga akan menimbulkan respon nyeri (Bobak, et al., 2005).

Pengalaman melahirkan dapat dipandang sebagai periode paling membahagiakan bagi kehidupan seorang perempuan yang diasosiasikan dengan kebahagiaan dan perayaan kelahiran buah hati. Disamping itu, pengalaman melahirkan juga sering dikaitkan dengan emosi negatif, seperti perasaan ketakutan, kecemasan, tidak aman dan kekhawatiran akan nyeri (Karlsdottir, et al., 2015). *The International Association for the Study of Pain* (IASP) mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan, yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan

baik aktual maupun potensial (IASP, 2017). Sedangkan nyeri melahirkan adalah rasa tidak nyaman yang terjadi selama proses persalinan.

Nyeri melahirkan memiliki dua elemen, yakni viseral dan somatik. Nyeri viseral terjadi pada kala satu persalinan yang diakibatkan oleh perubahan pada serviks, distensi segmen bawah uterus, peregangan jaringan serviks saat berdilatasi, dan adanya tekanan pada struktur dan saraf di sekitarnya. Nyeri viseral akan terasa di segmen bawah abdomen, dan menjalar ke area lumbosakral di punggung, krista iliaka, bokong, paha dan punggung bagian bawah. Sedangkan nyeri somatik akan muncul pada akhir kala satu persalinan sampai kala dua persalinan. Nyeri somatik disebabkan oleh peregangan dan distensi jaringan perineal dan dasar pelvis agar janin dapat melewati jalan lahir (Czech, et al., 2018; Lowdermilk, et al., 2013).

Nyeri merupakan pengalaman yang unik dan subjektif, dimana setiap individu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap nyeri karena ambang nyeri yang berbeda. Perbedaan respon terhadap nyeri tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pengalaman nyeri sebelumnya, kecemasan dan ketegangan emosi (Bobak, et al., 2005). Melalui pengalaman, ibu mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengatasi nyeri pada saat persalinan. Selain itu, ketegangan emosi akibat kecemasan dan ketakutan terhadap proses persalinan dapat memperberat persepsi ibu terhadap nyeri (Solehati, et al., 2018).

Nyeri Melahirkan sering dikaitkan dengan pengalaman psikologis yang merugikan bagi perempuan yang bersalin, kemajuan persalinan dan kesejahteraan janin. Pengaruh potensial dari nyeri melahirkan dapat berupa peningkatan konsumsi oksigen dan hiperventilasi yang dapat menyebabkan tingginya kadar karbondioksida dan alkalosis respiratori, serta stimulasi sistem saraf otonom dan produksi katekolamin, yang menyebabkan peningkatan resistensi pembuluh darah perifer, curah jantung dan tekanan darah, penurunan perfusi plasenta dan aktivitas urin yang tidak terkoordinasi (Santana, et al., 2015).

Pengalaman nyeri juga berhubungan dengan kesehatan ibu pasca persalinan. Ibu yang mengalami nyeri yang berat pada saat melahirkan dan ibu yang memiliki pengalaman persalinan yang negatif cenderung lebih berisiko mengalami *postpartum posttraumatic stress syndrome* dibandingkan ibu yang mengalami nyeri lebih ringan atau memiliki pengalaman persalinan yang positif. Maka dari itu perludilakukan berbagai upaya oleh perawat untuk mengurangi dampak nyeri melahirkan tersebut.

Manajemen nyeri dalam melahirkan merupakan salah satu dari tujuan utama keperawatan maternitas pada asuhan keperawatan pada ibu bersalin (SIKI, 2017). Manajemen nyeri persalinan pada kala I penting dilakukan oleh perawat sebagai pertimbangan apakah ibu dapat melanjutkan persalinan secara normal atau memerlukan tindakan karena adanya

penyulit akibat nyeri yang hebat (Solehati, et al., 2018). Berbagai metode manajemen nyeri farmakologi dan non-farmakologi dapat dipilih untuk mengurangi nyeri melahirkan. Manajemen nyeri farmakologis diantaranya menggunakan analgesik epidural atau opioid untuk ibu hamil sehat.

Pendekatan farmakologis ini merupakan metode invasive, dan berpotensi menimbulkan efek samping baik pada ibu maupun janin. Sedangkan manajemen nyeri non-farmakologis adalah metode yang non-invasif, dengan risiko komplikasi minimal atau tidak menimbulkan komplikasi pada ibu dan janin. Metode manajemen nyeri non-farmakologis diantaranya adalah mengatasi nyeri yaitu *hypnosis*, *massage*(*Massage endorphin*, *back massage*, *counterpressure*, *efflurage*), TENS, terapi kompres panas & dingin, terapi musik, *counterpressure* dan Akkupesur dan Akupuntur (Lowdermilk, 2013), teknik manual untuk manajemen nyeri aplikasi adalah teknis non farmakologis yaitu *hypnosis*, dan terapi Murrotal.

Terapi *hypnosis* merupakan salah satu manajemen ketidaknyamanan secara nonfarmakologis untuk mengontrol/mendistraksikan nyeri pada persalinan. *Hypnosis* adalah metode mengolah kata sedemikian rupa sehingga memperngaruhi alam bawah sadar seseorang dengan kata-kata yang menghidupkan jiwa, semangat dan dukungan melalui kalimat-kalimat lembut dari seorang perawat. Hal tersebut sangat di perlukan untuk meringankan penderitaan wanita yang sedang melahirkan. *hypnosis* dalam maternitas di beri nama *hypnobirthing*. Yang pertama memperkenalkan

metode *hynobirthing* di Indonesia yaitu Kuswandi (2014) dengan nama Gaung *hypnobirthing*. *Hypnobirthing* adalah perpaduan antara *Body* (badan), *Mind* (pikiran/ perasaan) dan Spirit (jiwa). Dengan adanya *hypnobirthing* ini membuat persalinan yang dianggap menyakitkan berubah menjadi suatu pengalaman yang alami dan wajar yang dirasakan seorang wanita pada saat melahirkan. Dengan menggunakan metode ini, maka badan menjadi rileks dan pikiran menjadi lebih tenang. Selain dengan kata-kata afirmasi, sugesti dan relaksasi pikiran, *hypnobirthing* juga memadukan teknik ideomotor untuk mengantarkan klien lebih mudah untuk masuk kedalam kondisi rileks di semua lapisan terdalam. Dengan adanya perpaduan gerakan ini akan merangsang otak untuk memerintahkan kelenjar hipofisis memproduksi hormon yang bernama hormon *endorfin*. Keluarnya hormon *endorphin*, nyeri tersebut dapat di distraksikan dengan membayangkan sesuatu yang indah dan gerakan ideomotor yang lembut.

Metode lain untuk mengurangi nyeri melahirkan adalah menggunakan Murrotal, dengan terapi murrotal Al Qur'an dengan tempo yang lambat serta harmonis dapat menurunkan hormon- hormon stress dan mengaktifkan hormon *endorfin* yang diketahui sebagai analgesik alami. Sehingga dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dapat menenangkan jiwa sekaligus mengurangi nyeri. Murrotal secara langsung dapat menekan nyeri dengan stimulus melalui *auditor (pendengaran)*

BAB 2

Hypnobirthing dan Murrotal

A. Hypnobirthing

1. Hypnosis

a. Definisi

Hyponosis adalah suatu gejala alami sehari-hari, suatu fenomena psikologis biasa yang pernah dialami setiap orang. Setiap orang nyaris secara tidak sengaja pernah melakukan praktik hipnotis alamiah, setidaknya menerapkan pemberian sugesti kepada orang lain atau sebaliknya. IBH, 2015).

Hypnobirthing adalah bagian dari *Hyponosis* yang telah dimodifikasi bertujuan untuk mendapatkan suatu pengalaman saat persalinan yang menyenangkan, natural dan perasaan tenang (Kuswandi, 2013).

Teknik hypnosis dalam persalinan menekankan pada peningkatan relaksasi, pengurangan rasa takut, kecemasan, dan persepsi nyeri. *Hypnobirthing* adalah Teknik yang mudah di pelajari dalam

melibatkan relaksasi mendalam, pola pernafasan lambat, dan petunjuk melepas endorfin dari dalam tubuh (relaksan alami tubuh) yang memungkinkan calon ibu menikmati proses kelahiran yang aman, lembut, cepat, dan tanpa proses pembedahan. *Hypnobirthing* berkerja akan kekuatan sugesti. Proses ini menggunakan afirmasi positif, sugesti dan visualisasi untuk menenangkan tubuh, memusatkan pikiran, serta mengendalikan nafasnya.

Hypnobirthing bisa menjadi salah satu cara ibu yang sedang intra natal belajar untuk bisa memahami apa yang mau oleh tubuh kemudian dapat menerima diri serta proses yang terjadi selama persalinan dengan ikhlas dan damai. Latihan *hypnobirthing* juga harus menyelaraskan antara tubuh, pikiran dan jiwa. Teknik *hypnobirthing* ibu harus dalam kondisi tentram dan sehat. Ikatan antara tubuh, pikiran dan jiwa yang saling berkaitan satu sama lain sebab ketiga unsur tersebut saling berpengaruh.

1. Tubuh

Tubuh adalah bagian terpenting pada saat melahirkan, karena dengan tubuh yang sehat ibu dapat menjalani proses persalinan dengan normal. Cara memelihara kesehatan tubuh ibu pada saat hamil seperti olahraga ringan, berenang, senam hamil yang melakukan relaksasi dan yoga lebih tenang dan nyaman pada saat menghadapi persalinannya.

2. Pikiran

Pikiran seorang ibu sangat dapat mempengaruhi ibu selama melahirkan. Bila pada saat melahirkan emosi ibu tidak dapat dikendalikan dan mengalami stress merubah kestabilan syaraf dan otak (neuro), hormon, kelenjar (endokrin), daya tahan tubuh dan akhirnya pada masalah kesehatan. Hal ini juga berpengaruh pada kekuatan ibu dalam mengatasi nyeri. Sebaliknya apabila ibu berpikiran positif merasa bahagia, damai dan tentram otomatis ibu tahu bagaimana cara mengatasi nyeri dan dapat melahirkan dengan normal. Kondisi pikiran ibu pada saat melahirkan mempengaruhi fisik karena akan memperberat kerja jantung, tekanan darah produksi adrenalin, aktivitas keringat, sekresi asam lambung dan lain-lain. Untuk memperoleh tubuh sehat selaras jiwa, dengan berbagai cara diantaranya melakukan pemusatan pikiran dan relaksasi.

3. Jiwa

Keadaan diri sebagai makhluk yang mempunyai Tuhan berkaitan erat dengan jiwa seorang ibu. Kesadaran ibu pada proses melahirkan diharapkan bisa menerima dengan ikhlas, sabar dan tawakal. Persalinan sendiri adalah kodrat seorang wanita untuk menjadi ibu. Cara untuk memperoleh harmonisasi tubuh, pikiran dan jiwa ini salah satunya dengan pemusatan pikiran

(contohnya sholat dan berdzikir dengan Khusus). Dengan memahami bahwa menyambut sebuah persalinan adalah sebuah proses jihad dan memahaminya sebagai kodrat seorang wanita. Sehingga dengan pemahaman tersebut maka proses persalinan akan lebih dirasakan tenang, damai, penuh cinta dan sedikit cidera (Kuswandi, 2014).

b. Manfaat Hypnobirthing

1) Untuk ibu

Sebagai formula yang alami dari pain management, pengobatan tidak memiliki efek samping terhadap janin, mampu menghadirkan rasa nyaman, rileks, dan aman. Mampu mengontrol sensasi rasa sakit pada saat berkontraksi rahim, memperlancar proses persalinan (kala 1 dan kala 2) mengurangi resiko terjadinya komplikasi dalam persalinan dan terjadinya perdarahan. Kondisi yang tenang membuat keseimbangan hormon di dalam tubuh, membantu menjaga suplai oksigen pada bayi selama proses persalinan.

2) Untuk janin

Getaran tenang dan damai akan dirasakan sebagai dasar dari perkembangan jiwa (SQ).

3) Untuk suami/ pendamping persalinan

Menjadi lebih tenang dalam mendampingi proses persalinan, emosi suami akan lebih stabil,

memperbaiki dan memperkuat hubungan juga ikatan batin antara istri, suami dan janin.

c. Fisiologis Hypnobirthing

Metode *hypnobirthing* yang tergolong termasuk tindakan non farmakologis dalam perawatan holistic. Cara kerja *hypnobirthing* paling utama adalah gabungan korteks cerebri yang berperan sebagai fungsi luhur yaitu gabungan prefrontal (pengambilan keputusan seperti mengukur dari suatu tindakan yang dilakukan dan memilih antara opsi yang bermacam-macam situasi sosial dan fisik, pada bagian ini dapat dimanipulasi informasi yang pakai untuk berpikir dan membuat rencana).

Gabungan korteks parietal – temporal - oksipital (mengintegrasikan pesan secara somatik, pendengaran, dan penglihatan yang dikerjakan untuk memproses gambaran lengkap mengenai suatu informasi) dan gabungan korteks limbik yang berkaitan dengan keinginan dan emosi yang daerah gabungan korteksnya saling bergantung di dalam substansia alba serebrum secara bersamaan.

Gabungan korteks tersebut menyatukan bermacam-macam informasi untuk melakukan suatu tindakan bagian tubuh seperti Hipotalamus dan sistem syaraf simpatis dan para simpatis (Sherwood, 2020). Kelenjar hipofisis yang menempel di hipotalamus,

mengeluarkan hormon yang bisa mengendalikan fungsi vital. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon yang berfungsi untuk menyesuaikan terhadap stres (Potter & Perry, 2005). Pada saat dilakukan *Hypnobirthing* dengan memberikan afirmasi positif stres dapat teratasi dan secara tidak langsung hipofisis dapat dikendalikan (Winarto, 2008 dikutip oleh Harahap, 2009). Pengendalian stres pada *hypnobirthing* dengan cara *hypnotis* diri / *self hypnotis* adalah memberikan afirmasi positif yang dilakukan oleh diri sendiri (Kroger, 2008).

Self hypnotis adalah belajar sendiri agar bisa menolong dirinya untuk sampai pada maksud pribadi dengan niat positif ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar dimulai saat otak dalam keadaan beristirahat, tidak tegang. Pada saat tubuh dalam keadaan istirahat/relaks akan menghasilkan hormon *serotonin* dan *endorfin*. Pada keadaan istirahat pikiran ini akan tampak gelombang otak yang di mulai dari gelombang beta akan turun ke gelombang alfa yang tercatat pada mesin EEG 8-12 Hz /CPS (Kroger, 2008, dalam Harahap, 2009).

d. Gelombang Yang Mempengaruhi

1) Beta, Frekuensi 12 – 25 Hz

Frekuensi beta merupakan kondisi pikiran anda sekarang ini, ketika duduk di depan computer atau ketika membaca artikel ini. Otak ketika

berpikir rasional, memecahkan masalah, dan keadaan pikiran dimana telah menghabiskan sebagian besar hidup anda keluar dari gelombang beta.

2) Alpha, Frekuensi 8 – 12 Hz

Periode transisi antara sadar dan tidak sadar. Gelombang alpha biasanya digunakan oleh para hypnoterapis mulai memberikan sugesti kepada pasiennya. Gelombang alpha terjadi pada saat kondisi seseorang biasa fokus pada satu subjek.

3) Theta, Frekuensi 4 – 8 Hz

Merupakan gelombang otak (*brainwave*) seseorang sedang tidur ringan, atau sangat mengantuk. Tanda-tandanya napas mulai melambat dan dalam. Gelombang ini dinamakan fase *trance* (contohnya saat seseorang khusuk dalam menjalani ritual agama).

4) *Delta*, Frekuensi 0,1 – 4 Hz

Bersifat seperti tidur tanpa mimpi menemukan media guna mengukur gelombang otak berdampak positif bagi kemajuan hypnosis.

B. Murrotal

1. Definisi

Murottal merupakan rekaman suara Al-Qur'an yang dilagukan oleh seorang Qori' (pembaca Al-Qur'an). Lantunan Al-Qur'an secara fisik mengandung unsur suara manusia, suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling

mudah dijangkau (Siswanti, 2017). Suara dapat menurunkan hormon- hormon stres, mengaktifkan hormon *endorfin* alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa nyeri, Pendekatan spiritual dapat membantu mempercepat pemulihan atau penyembuhan klien (Siswanti, 2017).

2. Manfaat

Kitab suci agama islam adalah Al-Qur'an, yang dijadikan petunjuk hidup umatnya. Manfaat dari Al-Qur'an salah satunya adalah penyembuh (As-syifa). Kata penyembuh disini menyatakan Al-Qur'an bisa dijadikan obat dari penyakit jasmasni dan rohani. Khusus dalam ilmu kedokteran peran Al-Qur'an sangat besar dalam proses penyembuhan fisik dan non fisik. Penyembuhan secara non fisik paling banyak digunakan, seperti penyakit jiwa, kegelisahan, stress kesedihan. Dengan lantunan suara yang lembut dapat menurunkan hormon stress karena suara manusia adalah salah satu instrument yang dapat menyembuhkan dan sangat indah serta mudah didapatkan. Dengan lantunan suara yang indah dan lembut dapat menjadi aktifitas gelombang otak lebih baik untuk memperlambat kerja detak jantung, denyut nadi dan tekanan darah. Suara dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon *endorfin* alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa nyeri. Pendekatan spiritual dapat membantu mempercepat pemulihan atau penyembuhan klien (Siswanti, 2017).

3. Cara Kerjanya Mekanisme

Cara kerja murrotal dengan menstimulasi otak untuk menghasilkan zat kimia yang bernama *zat neuropeptide*. Zat ini akan masuk dalam reseptor dan menghadirkan perasaan puas dan senang (Abdurroccman, 2008). Stimulasi yang di terima oleh telinga akan membuat bergetar membran timpani, dengan getaran yang dilanjutkan ke tulang pendengaran yang berkaitan satu dan yang lainnya. (Elsa, 2015).

Stimulasi fisik yang dirubah karena ada perberdaan ion kaliun dan ion natrium menjadi aliran listrik melalui Nervus VIII (*vestibule cochlearis*) ke otak. Setelah otak mengalami potensial aksi yang di hasilkan oleh syaraf auditorius, meneruskan perubahan potensial pada korteks auditorius yang bertanggung jawab untuk menganalisa suara yang kompleks. Ingatan yang pendek dan perbandingan nada diterima oleh asosiasi korteks temporalis parietal, oksipital di teruskan ke gabungan korteks prefrontal dan terakhir pada korteks asosisasi limbik lalu menstimulasi amigdala di bagian sistem limbik pusat yang mempengaruhi emosi dan prilaku manusia dan terakhir tersimpan di hipocampus. Ingatan tersebut akan secara sadar atau tidak akan terpanggil bila mendapat stimulasi. (Sherwood, 2012).

Penurunan kegelisahan, kecemasan ketakutan serta mendapatkan ketenangan jiwa dengan mengindahkan ayat-ayat suci Al-Quran melalui suara secara rutin akan mendapatkan perubahan fisiologis sangat besar pada fisik

maupun non fisik (Siswantinah, 2011). Murottal al-Qur'an adalah memahami dengan dua kebenaran Al-Qur'an, pertama dengan fokus pada bacaan Al-Qur'an dan lantunan suara dengan tingkat sedang. Jadi murottal adalah salah satu nada musik yang mempunyai pengaruh positif untuk yang mendengarkannya (Widayarti, 2011). Oleh sebab itu bacaan Al-Quran dikatakan perawatan Holistik karena bisa meningkatkan perasaan nyaman dan tenang (Risnawati, 2017). Tingkat aliran lagu dengan suara yang lembut biasanya antara kurang lebih 60 desibel yang dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan pada pendengaran. Bila untuk terapi murrotal durasinya antara 15-25 menit.

C. Aplikasi Asuhan Keperawatan menurut Katharine Kolcaba

Menurut Kolcaba, *comfort* yang dikembangkan menyebutkan *holistic comfort* merupakan bentuk kenyamanan yang meliputi tiga tipe *comfort* yaitu *relief*, *ease*, dan *transcendence* yang digabungkan dalam empat konteks yaitu: *physical*, *psychospiritual*, *sociocultural* dan *environmental*.

1. Tipe Kenyamanan

a. Relief (Kelegaan)

Merupakan suatu kenyamanan, dari hasil penelitian Orlando (1961) mengemukakan bahwa perawat meringankan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien atau diartikan keadaan pasien yang kurang nyaman dan belum menemukan keadaan yang khusus.

b. Ease (Ketentraman)

Merupakan arti kenyamanan dari hasil penelitian Henderson (1966), yang mendeskripsikan ada 13 fungsi dasar manusia harus dipertahankan selama pemberian asuhan memberikan ketenangan atau kelegaan kepada pasien.

c. *Transcende* (Kenyamanan)

Mempunyai arti kenyamanan, dari hasil penelitian Paterson dan Zderad (1975) yang menjelaskan bahwa perawat membantu pasien dalam mengatasi kesulitannya atau dimana seorang pasien sudah mampu menyesuaikan dengan kodisinya.

2. Konteks dimana terjadi kenyamanan

a. Fisik

Kenyamanan fisik berhubungan dengan keluhan-keluhan yang di rasakan oleh badan seorang pasien.

b. *Psychospritual*

Berhubungan dengan gambaran diri, kepribadian, pandangan, perilaku seksual, arti dari suatu interaksi manusia dengan aturan atau keberadaan sang pencipta.

c. *Sociocultural*

Interaksi antara orang lain, keluarga dan keadaan sosial.

d. *Environmental*

Kenyamanan yang berkaitan dengan penerangan, privasi kenyamanan tempat istirahat, kenyamanan berinteraksi dengan keluarga, kebersihan dan lain-lain.

	Relief	Ease	Transcendence
Physical			
Psychospiritual			
Environmental			
Sociocultural			

Gambar 2.1 Struktur Taksonomi Kenyamanan (*Comfort*)

BAB 3

Hypnobirthing dan Murrotal Sebagai Pengurang Nyeri Melahirkan Pada Ibu Intranatal

A. Ruang Lingkup Intranatal

1. Pengertian Intranatal

WHO mendefinisikan persalinan normal sebagai persalinan yang diawali dengan cara langsung tanpa direncanakan (memakai tenaga ibu sendiri dengan melewati jalan lahir), meminimalkan resiko sebelum persalinan dan presentasi bagian ubun-ubun kecil pada usia kehamilan kurang lebih 40 minggu dengan kondisi ibu maupun bayi sehat.

Melahirkan adalah proses dimana janin, ari-ari dan kulit ketuban keluar dari rahim seorang ibu. Persalinan di katakan normal apabila prosesnya terjadi pada usia kehamilan yang cukup bulan tanpa dibarengi adanya

komplikasi penyerta. Persalinan diawali (*inpartu*) mulai dari rahim berkontraksi dan menimbulkan keadaan berubah pada mulut rahim (mulut rahim terbuka lalu terjadi penipisan pada dinding rahim dan berakhir dengan keluarnya ari-ari secara utuh).

Melahirkan merupakan proses memindahkan janin, plasenta dan selaput ketuban, keluar dari uterus melalui jalan lahir. Berbagai perubahan dapat terjadi pada sistem reproduksi wanita dalam beberapa hari dan minggu sebelum persalinan dimulai. Persalinan sendiri dapat berarti mekanisme yang terlibat dalam proses dan tahapan yang dilalui wanita (Lowdermilk, dkk : 2013).

Melahirkan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Harianto, 2010). Intranatal atau persalinan merupakan proses alamiah, yakni merupakan serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Erawati, 2011).

2. Teori Persalinan

a. Teori Awitan Persalinan

Teori ini menjelaskan terjadinya ketika janin sudah cukup bulan untuk hidup di luar kandungan dan janin tidak menimbulkan masalah dalam proses persalinan.

Namun banyak peneliti yang bertanya asal mula timbulnya persalinan yang difokuskan pada kelarasan antara kadar hormon yang terlihat menimbulkan kontraksi persalinan dengan kadar hormon yang condong mengistirahatkan otot uterus.

b. Teori Hormon Estrogen – Progesteron

Teori ini menjelaskan tentang perbandingan estrogen dan progesteron berguna untuk menjaga kehamilan dan proses persalinan. Kadar kedua hormon tersebut dapat mengatur perubahan konsentrasi reseptor oksitosin ke bentuk uterus. Penelitian pada hewan penurunan peredaran progesteron menstimulasi kontraksi uterus dengan meningkatkan pembentukan celah pertautan serta meningkatkan terbentuknya prostaglandin E_2 (PGE), estrogen meningkatkan sintesis lokal PGE₂ (Ziantik, 1994 dalam Reeder Martin, 2014). Pada beberapa tahun diyakini bahwa awitan persalinan dihasilkan dari penurunan progesteron saat estrogen relatif mendominasi.

c. Teori Oxytocin

Teori oksitosin mengatakan bila oksitosin merangsang kontraksi rahim untuk melakukan kegiatannya dengan cara langsung ke miometrium dengan cara tidak langsung menaikkan proses pengeluaran prostaglandin di daerah desidua. Rahim makin sensitif pada oksitosin sejalan dengan usia kehamilan. Kandungan paling tinggi kadar oksitosin dalam darah telah akan dijumpai kala dua dalam melahirkan. Sebab manusia dan mamalia menjalani saat melahirkan

secara normal meskipun hipofis yang mengeluarkan oksitosin sudah diangkat atau menderita rusak, yang terlihat tidak mungkin bahwa hormon oksitosin ini dengan cara sendiri mengawali rangkaian persalinaan.

d. Teori Kontrol Endokrin Janin

Teori endokrin janin mengatakan bahwa pada waktu janin sudah matang, kelenjar adrenal janin mengeluarkan kortikosteroid yang menggerakkan kerja melahirkan, steroid janin merangsang terlepasnya prekursor ke prostaglandin, pada akhirnya membuat kontraksi persalinan pada rahim (Casey, et al, 1985 dalam Reeder Martin, 2014) pada saat sebelum persalinan kepekaan kelenjar adrenal janin pada hormon adrenokortikotropik, diproduksi oleh hipofis naik. Dengan kenaikan produksi hormon adenokortikotropik menimbulkan kenaikan produksi kortisol. Pelepas kortikosteroid waktu stress dan sudah diusulkan menjadi salah satu sebab bisa melahirkan secara prematur. Keadaan tersebut dapat terjadi kalau kondisi janin dalam bahaya, contohnya preeklampsia, pembesaran rahim yang berlebihan kehamilan kembar atau kelebihan air ketuban pada masa kehamilan.

e. Teori Prostaglandin

Teori prostaglandin mengatakan bahwa persalinan diawali dari serangkaian peristiwa, dimulai dari melepas prekursor lipid yang digerakkan karena adanya kegiatan steroid. Pada proses ini juga terjadi pelepasan asam arakidonat oleh prekursor pada

bagian samping membran janin. Terjadinya kenaikan sintesis prostaglandin melalui asam arakidonat juga dapat meningkatkan kontraksi uterus sebagai akibat dari kegiatan prostaglandin ke otot rahim (Bennet et al, 1990 dalam Reeder Martin, 2014). Studi tentang sintesis prostaglandin menunjukkan bahwa asam arakidonat, prekursor wajib pada prostaglandin meningkat secara nyata pada perbandingan dengan asam lemak lain dicairkan amnion wanita dalam proses persalinan (Reddi et al., 1987 dalam Reeder Martin, 2014). Prostaglandin efektif dalam menginduksi kontraksi uteri pada setiap tahap kehamilan (Cunningham, et.al, 1993 dalam Reeder Martin, 2014). Prostaglandin dihasilkan dari desidua uteri, tali pusat dan air ketuban. Cara menemukan riset beragam tentang kandungan prostaglandin yang naik pada cairan ketuban dan darah maternal saat sebelum terjadi melahirkan (Ilancheran et al, 1990 dalam Reeder Martin, 2014). Apapun yang terjadi, komposisi prostaglandin diketahui meningkat pada saat dan setelah melahirkan.

B. Konsep yang Mempengaruhi Persalinan

1. Kekuatan/*Power*

Kekuatan adalah kemampuan untuk melahirkan yang terdiri dari his (kontraksi rahim) serta kemampuan mengedan seorang ibu. Power merupakan tenaga dasar atau kemampuan penting yang harus yang di peroleh dari kontraksi serta retraksi otot-otot rahim. His yaitu

kontraksi otot-otot rahim saat persalinan. Kontraksi adalah keadaan gerak memendek dan menebalnya otot-otot rahim yang terjadi diluar kesadaran (involuter) dan dibawah kontrol syaraf simpatik. Retraksi adalah pemendekan otot-otot rahim yang bersifat menetap sesudah kontraksi. His yang normal adalah awal mulai timbul dengan perlahan dan teratur, semakin lama semakin bertambah kuat dan sampai pada puncak yang paling kuat setelah itu sedikit demi sedikit melemah akhirnya menjadi lemah. His semakin lama semakin singkat dan teratur iramanya dengan rangkaian tindakan suatu persalinan sampai bayi dikeluarkan. Kemampuan meneran merupakan kekuatan kedua yang bertindak pada proses persalinan, kemampuan ini dipakai pada waktu kala 2 dan untuk membantu mendorong bayi keluar, asal dari kemampuan ini dari otot perut dan diafragma. Meneran memberikan kekuatan yang sangat menolong untuk mengatasi resistensi otot-otot dasar panggul. Persalinan akan berjalan dengan normal, apabila his dan tenaga untuk meneran ibu kuat.

Dalam mengawasi persalinan hendaknya selalu dibuat daftar tentang His:

- a. Frekuensi: adalah jumlah his dalam waktu tertentu biasanya per 10 menit.
- b. Amplitudo/intensitas: adalah kekuatan his diukur dalam satuan mmHg, Aktivitas his : adalah lamanya setiap his berlangsung diukur dengan detik.

2. Jalan Lahir/*Passage Way*

Jalan lahir tempat yang mesti dilalui janin, jalan lahir harus dilewati janin tanpa ada suatu hambatan. Oleh sebab itu jalan lahir itu harus normal dengan panggul yang berbentuk Ginekoid, bentuk panggul yang Ginekoid harus mempunyai bentuk nyaris bulat rongga panggul bagian atas serta bagian sacrum lebar dan melengkung, pada promontorium tidak meyembul ke arah depan, kedua spina ischiadica menonjol keluar, pojok lingkaran pubis luasnya (antara 90-100), dengan panjang conjugata vera (ukuran bagian belakang pintu atas panggul dari bawah simpisis ke promontorium panjangnya sekitar 10-11 cm), panjang garis tengah transversa melintang pintu atas panggul kira-kira 12-14 cm, diameter oblique (panjangnya serong pintu atas panggul yaitu 12-14 cm, dan pintu bawah panggul ukuran muka melintang 10-10,5 cm. serta jaringan lunak yang berada di sekitar panggul.

3. Penumpang/*Passenger*

Faktor *passenger* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses persalinan yang biasa disebut dengan faktor penumpang. Janin pada usia kehamilan 36 minggu sudah masuk PAP (Pintu Atas Panggul), Placenta, cairan amnion yang mulai dihasilkan usia kehamilan 10-36 minggu dengan jumlah normal 1000 cc. Cara *passenger* atau janin dipengaruhi oleh ukuran kepala janin, presentasi janin, letak janin, sikap Janin, posisi janin.

4. Psikologis

Keadaan psikologis atau perasaan ibu bisa terlihat dari tingkat emosi relatif labil yang sehingga dapat menurunkan kemampuan ibu untuk mrngontrol nyeri pada saat persalinan menurut Gorrie, Mc Kinnney dan Murray (2000) dalam Harahap (2009), ibu akan Ketokolamin karena ada perasaan takut, cemas, dengan keluarnya ketokolamin dapat menghambat kontraktilitas dan aliran darah ke plasenta. Oleh sebab itu pada saat persalinan keadaan pikiran ibu harus dalam kondisi tenang.

C. Proses Persalinan

1. Cara Kerja Persalinan

Cara kerja persalinan adalah pergerakan janin dari panggul keluar dari vagina, ada 7 tahapan cara kerja persalinan

a. Turunnya presentasi (*Engagement*), meliputi:

- 1) Masuknya presentasi ke dalam pintu atas panggul
- 2) Pada saat sutura sagitalis berada di pertengahan jalan lahir, disympisi dan promotorium dikatakan synclitismus. pada synclitismus os.parietal depan dan belakang sama tingginya jika sutura sagitalis agak kedepan mendekati symfisis atau agak kebelakang mendekati promotorium dikatakan Asynclitismus.
- 3) Pada saat sutura sagitalis berdekatan symfisis dikatakan asynclitismus posterior namun bila

kebalikannya dikatakan asynclitismus anterior. Untuk menentukan sampai dimanakah bagian terendah janin turun dalam panggul (bidang hodge)

- a) H I bidang Hodge yang sudah dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium.
- b) H II sejajar dengan *Hodge I*, setinggi bagian bawah simfisis III sejajar *Hodge I, II*, setinggi spina ischiadica kiri dan kanan.
- c) H IV sejajar bidang *Hodge I, II, III* setinggi os coccygeus.

b. Penurunan

Pada primigravida, penurunan merujuk pada kemajuan bagian yang di presentasikan melewati panggul. Penurunan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

- 1) Tekanan yang ditimbulkan oleh cairan amnion.
- 2) Tekanan langsung oleh kontraksi fundus pada janin.
- 3) Kemampuan ibu dalam melakukan meneran.
- 4) Gaya janin meluruskan tubuh.

c. Fleksi

Segara sesudah presentasi yang turun bertemu tahanan dari seviks, dinding panggul, lalu presentasi melakukan fleksi dan dagu mendekati dada janin dengan garis tengah suboksipitobregmatik (9,5cm) yang lebih kecil yang dibandingkan garis tengah lebih besar keluar melalui pintu keluar panggul.

d. Rotasi internal

Diawali pada di spina ichium tapi tidak lengkap hingga bagian yang di presentasikan sampai di panggul bawah, pda saat oksiput berputar kebagian kerarah depan dan muka berputar kearah belakang setiap kontraksi kepala janin ditujukan ke bagian tulang panggul dan otot- otot dasar panggul. Terakhir oksiput akan berada di tengah pada bawah tulang arkus pubis. Kepala senantiasa berputar bila telah sampai dasar panggul.

e. Ekstensi

Pada saat presentasi sudah sampai perineum akan dilahirkan, maka presentasi akan terdefleksi kebagian anterior oleh perineum. Oksiput melalui bawah simfisis pubis dulu setelah itu presentasi muncul pada posisi ekstensi, yang pertama keluar yaitu oksiput, muka dan yang terakhir dagu.

f. Resusitasi dan Rotasi eksternal

Resusitasi adalah gerakan sesudah presentasi dilahirkan, maka presentasi akan berputar ke posisi awal pada saat turun bersama pintu atas panggul. Sedangkan rotasi eksternal terjadi pada saat bahu turun dengan manuver yang serupa dengan presentasi, bahu bagian depan turun terlebih dulu. Saat sampai pintu atas panggul bahu berotasi ke diameter serta dikeluarkan dari bawah arkus pubis, bahu bawah diarahkan ke bagian perineum, sampai bebas dari introitus vagina.

g. Dorongan keluar

Sesudah mengeluarkan bahu, kepala dan bahu diambil sebagian tulang pubis ibu dan badan bayi dilahirkan dengan menekuknya ke arah lateral bagian simfisis pubis . saat bayi telah terlihat lengkap.

D. Manajemen Nyeri Melahirkan

1. Neurologi

Nyeri dan ketidaknyamanan saat persalinan mempunyai dua sumber, somatik dan viseral. Saat kala satu persalinan, kontraksi uterus akan menyebabkan dilatasi dan penipisan (*Effacement*) serviks. Iskemia uterus (penurunan suplai darah, sehingga terjadi deficit oksigen) di sebabkan oleh kompresi arteri yang menyuplai miometrium saat uterus berkontraksi. Rangsangan nyeri pada kala satu persalinan akan di transmisikan lewat segmen syaraf spinal T-1 sampai T-12 syaraf toraks bawah dan simpatik lumbal atas .syaraf-syaraf ini berasal dari korpus dan serviks (Blackburn 2007, di kutip Lowdermilk, 2013).

Nyeri disebabkan oleh perubahan serviks, distensi serviks berdilatasi, dan tekanan pada struktur dan syaraf sekitarnya merupakan nyeri viseral. Nyeri tersebut akan terasa dibagian bawah perut. Nyeri viseral atau *Referred Pain* terjadi ketika nyeri yang berasal dari uterus menjalar ke dinding abdomen, area lumbosakral di punggung, kista iliaka, bokong, paha, dan punggung bagian bawah (Blackburn, 2007, Zwellings,dkk, 2006 dalam Lowdermilk,

2013).

Pada kala dua persalinan ,wanita akan mengalami nyeri somatik, yang sering dideskripsikan sebagai nyeri yang tajam, intern, terasa panas seperti terbakar, lokasi nya jelas. Nyeri berasal dari peregangan dan distensi jaringan perineal dan dasar pelvis agar fetus dapat lewat, dari distensi dan tertariknya peritoneum dan jaringan pendukung uteroserviks saat kontraksi, dan laserasi di jaringan lunak (contoh: serviks, vagina, perineum) faktor fisik lainnya yang berhubungan, kontraksi dan rasa lelah (Zweelling dkk, 2006). Rangsangan nyeri pada kala dua persalinan lewat syaraf puddendus lewat segmen S-2 samapai S-4 akan di transmisikan tulang belakang dan syaraf parasimpatis (Blackbrun, 2007).

2. Persepsi Nyeri

Ambang nyeri semua oarang hampir sama tanpa melihat jenis kelamin, perbedaan sosial, suku dan budaya, rangsangan berlawanan, dan pengalih perhatian dalam menghadapi nyeri masih belum di mengerti sepenuhnya . arti nyeri dan ekspresi verbal dan non verbal terhadap nyeri tampaknya di pelajari melalui interaksi dengan kelompok sosial primer. Pengaruh kebudayaan akan memberikan suatu harapan yang bisa atau tidak bisa di terima ketika mengalami nyeri.

3. Ekspresi Nyeri

Rasa nyeri akan mengakibatkan efek fisiologis, respons sensorik, dan emosional. Selama persalinan nyeri akan menimbulkan efek-efek fisiologia yang dapat diidentifikasi. Aktivitas sistem syaraf simpatik akan menstimulasi sebagai respon nyeri yang makin meningkat, sehingga terjadi peningkatan kadar ketokolamin. Tekanan darah dan denyut jantung akan meningkat. Pola respirasi ibu akan berubah sebagai respon terhadap peningkatan kadar oksigen. Hiperventilasi kadang bersamaan dengan alkalosis respirasi, dapat terjadi selama rasa nyeri meningkat.

4. Faktor yang Mempengaruhi Nyeri

a. Budaya

Sistem kebudayaan dan kepercayaan agamanya akan menentukan bagaimana mereka mempersepsikan, menginterpretasikan, merespon, mengatasi rasa nyeri mereka.

b. Faktor Fisiologis

Wanita dengan riwayat disminorea dapat mengalami rasa nyeri yang meningkat yang disebabkan oleh kadar prostaglandin yang tinggi. Nyeri punggung pada saat mentruasi dan menyebabkan nyeri punggung pada saat kontraksi. Faktor fisik lainnya adalah kelelahan, durasi, kontraksi. Posisi fetus, kecepatan penurunan fetus, dan posisi ibu (Zwelling, 2006 dalam lowdermilk, 2013).

c. Emosi dan cemas

Kecemasan yang berlebihan dan rasa takut akan menyebabkan sekresi ketokolamin tambahan yang meningkat rangsang dari panggul ke otak karena penurunan aliran darah dan peningkatan tegangan otot, aktivasi ini nantinya akan meningkat persepsi nyeri (Zwelling, 2006 dalam Lowdermilk, 2013). Saat rasa takut dan kecemasan meningkat, tegangan otot akan meningkat, efektivitas kontraksi uterus berkurang, meningkat ketidaknyaman.

d. Pengalaman sebelumnya

Nyeri sensorik pada wanita nulli para seringkali lebih besar daripada wanita multipara pada awal persalinan (pembukaan kurang dari 5 cm) karena struktur saluran reproduksi yang tidak supel. Pada fase transisi kala satu persalinan dan awal kala dua persalinan, wanita multi para mungkin sensori yang lebih besar karena jaringan mereka yang lebih supel akan mempercepat penurunan kepala fetus, meningkatkan rasa nyeri. Jaringan wanita nulli para yang lebih keras akan membuat penurunan lebih lambat dan bertahap.

e. Teori pengontrolan nyeri

Fenomena ini mungkin terjadi karena beberapa kelompok sel syaraf dimedulla spinalis, batang, otak dan korteks serebral mempunyai kemampuan untuk mengatur rangsangan nyeri melalui suatu mekanisme pemblokiran. Teori pengontrolan nyeri ini membantu menjelaskan cara kerja hipnotis dan teknik mengurangi nyeri lainnya yang diajarkan di kelas

persiapan melahirkan. Berdasarkan teori ini rasa sakit akan menjalar searah jalur sensorik ke otak, namun kuantitas rasa atau pesan tertentu yang bisa berjalan di luar jalur ini pada satu waktu. Cara pengalihan perhatian contohnya pijat, musik, gambar serta titik fokal akan mengurangi atau memblokir sepenuhnya kapasitas jalur syaraf untuk mengantarkan rasa nyeri.

f. Kenyamanan

Keinginan dan kebutuhan yang terpenuhi akan memberikan perasaan nyaman, intervensi yang paling membantu dalam meningkatkan kenyamanan adalah pendekatan perawatan yang penuh perhatian dan dukungan yang penuh dari keluarga.

g. Lingkungan

Kualitas lingkungan dapat mempengaruhi persepsi terhadap nyeri. Lingkungan termasuk orang di dalamnya (bagaimana mereka berkomunikasi, filosofi perawatan, kebijakan dalam praktik dan kualitas dukungan) (Zwelling,Dkk 2006 dalam Lowdermilk, 2013).

5. Variabel Nyeri Persalinan

a. Nyeri Visceral

Nyeri yang disebabkan oleh kerusakan organ internal karakteristik bersifat difus dan dapat menyebar kebeberapa arah. Durasinya bervariasi tetapi biasanya berlangsung lebih lama dari pada superficial. Pada nyeri ini juga menimbulkan rasa tidak menyenangkan, berkaitan dengan mual dan gejala -gejala otonom

nyeri dapat terasa tajam, tumpul atau unik tergantung organ yang terlibat. Nyeri viseral ini terjadi pada persalinan Pembukaan serviks dilatasi & peregangan serviks dan segmen bawah uterus, nyeri melalui plexus hypogastric, masuk ke tl belakang di daerah T10, T11, T12, L1.

b. Nyeri somatic

Nyeri yang terjadi pada otot dan tulang serta struktur peyokong lainnya. Penekanan dan penarikan struktur pada panggul (ligamentum, tuba falopi, ovarium, vesica urinaria, peritoneum nyeri visceral terasa menjalar di punggung & kaki, distensi pada vagina & perineum karena penurunan janin sensasi terbakar, robek, terpisah masuk ke tl belakang pada S2, S3 dan S4).

c. Teori *Gate Control*

Pendapat tentang kontrol nyeri dikemukakan oleh Melzack dan Wall (1965) yang diberi nama *Gate Control*. Melzack dan Wall mengemukakan bahwa ada implus nyeri akan dikontrol dan di kendalikan oleh suatu sistem yang bernama mekanisme pertahanan yang berada pada bagian susunan syaraf pusat. pada saat implus nyeri aliran mya di teruskan pada bagian sinaps-sinaps dibagian kornu dorsalis ini membuka pintu dan pada saat bersama upaya mekanisme pertahanan menutup implus nyeri sehingga tidak sampai ke otak Usaha untuk menutup pertahanan adalah dari dasar teori menghilangkan nyeri.

Transmisi nyeri dapat dirubah/diblok oleh *counter stimulation*. Selama persalinan, impuls nyeri berjalan dari uterus sepanjang serat saraf halus (C-fibers) ke bagian atas menuju substansi gelatinosa di dalam *spinal column*. Kemudian sel transmisi menggambarkan kan pesan nyeri ke otak. Stimulasi taktil contohnya pijatan, kompres panas/dingin mengakibatkan pesan yang berlawanan yang lebih kuat, cepat dan berjalan sepanjang serat saraf besar (A-delta fibers). Pesan yang ini menutup *gate* di substansi gelatinosa kemudian memblok pesan nyeri. Otak tidak akan mencatat pesan nyeri yang diblok tersebut/ persepsi nyeri tidak dirubah. Kegiatan yang melibatkan *cortex cerebral*, seperti kontrol pernapasan, distraksi dan *imagery* juga mengaktifkan mekanisme *gate* sampaikan oleh impuls ke arah bawah melalui *spinal column* untuk menutup *gate* pada substansi gelatinosa.

d. *Endogeneous opiat theory*

Suatu teori pereda nyeri yang relatif baru di kembangkan oleh Avron Goldstein (1970-an) dimana ia menemukan bahwa terdapat substansi seperti opiate yang terjadi secara alami didalam tubuh. Subtansi endorphine. Yang berasal dari kata endogeus dan Morphine. Goldstein mencari reseptor morphine dan heroin menemukan bahwa reseptor dalam otak cocok dengan adanya molekul-molekul morphine dan heroin. Letak *endorfin* bagian syaraf-syaraf otak dan

sepanjang tulang belakang. *Endorfin* mempengaruhi transmisi implus yang diinterpretasikan sebagai nyeri kemungkinan bertindak sebagai neurotransmitter maupun neuromodulator yang menghambat transmisi dari pesan nyeri. Dengan *endorfin* disepanjang sistem syaraf sinaps bagian syaraf yang menyebabkan status penurunan dalam sensasi nyeri.

6. Fisiologis Nyeri Persalinan

Mulai dari turunnya kepala bayi ke rongga panggul lalu menstimulasi neuron aferen otonom berjalan ke atas melalui medulla spinalis dan batang otak. Walaupun sebagian besar serat aferen somatik akhirnya menuju hipotalamus, melalui feed back positif stimulasi yang berada di hipotalamus di teruskan melalui syaraf eferen menuju hipotalamus kemudian terakhir pada kortek serebri. Dikorteks serebri pada bagian hipofis posterior terstimulasi untuk memproduksi oksitosin. Setelah oksitosin diproduksi dalam darah dengan target otot-otot uterus. Kemudian uterus berkontraksi, kontraksi uterus semakin kuat yang menyebabkan dilatasi dan penipisan pada serviks akibat dilatasi dan penipisan pada serviks, maka daerah sekitar uterus mengalami penurunan aliran darah sehingga mengalami kekurangan oksigen disekitar uterus (iskemia) tersebut menimbulkan nyeri.

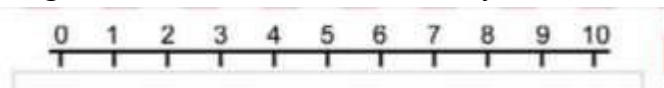
Nyeri dimulai dari segmen bawah dan peregangan serviks melalui fleksus hipogastrik masuk kedalam tulang belakang (T10,T11,T12,, L1). Penarikan dan peregangan sekitar punggung dinamakan nyeri visceral yang dirasakan sampai punggung kaki menjalarnya, dilanjutkan dengan distensi vagina dan perineum yang rasanya seperti dirobek, *terbakar* dan ditusuk- tusuk yang dimulai dari S1 sampai S4 dinamakan nyeri somatic.

7. Penilaian respon intensitas Nyeri

Penilaian intensitas nyeri dapat dilakukan dengan menggunakan sbagai berikut:

a. *Numerik Scale*

Penggunaan Numerik scale sangat membantu untuk mengganti pendeskripsi kata. Cara menggunakan skala numerik di mulai dngka 0-10. Skala ini sangat dianjurkan untuk menilai intensitas nyeri dengan ketentuan 10cm (Andarmoyo, 2013).

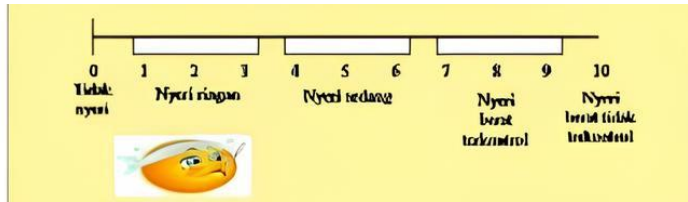


Gambar 3.1 Numerik rate scale pain

Sumber: <https://cdn.diedit.com/>

b. *Skala Deskriptif*

Alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang lebih objektif. Skala pendeskripsi verbal (verbal descriptor scale, VDS), pendeskripsi yang disusun dengan jarak yang sama di sepanjang garis. Pendeskripsi ini di rangking dari tidak "nyeri" sampai "Nyeri yang tidak tertahankan".

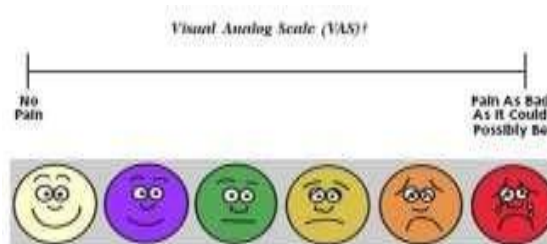


**Gambar 3.2 Skala Pendeskripsi Verbal
(verbal descriptor scale, VDS)**

Sumber: <https://slideplayer.info/slide/3244440/>

c. *Visual Analog Scale*

Adalah gambar wajah yang mendeskripsikan intensitas nyeri pada suatu garis lurus sepanjang 10 cm yang berkelanjutan sampai ke ujungnya.



Gambar 3.3 Visual Analog Scale

Sumber: <https://www.diedit.com/skala-nyeri/>

Tabel 3.1 Bagian dari Anamnesa Intensitas Nyeri

Faktor Penyebab	Pencetus Nyeri: Keadaan atau cara yang dapat menurunkan intensitas nyeri Penurun Nyeri: Keadaan atau cara yang dapat meningkatkan intensitas nyeri
Kualitas	Gambaran atau sensasi nyeri yang dirasakan seseorang seperti nyeri tajam, tumpul, terbakar, berdenyut, atau tertusuk
Daerah	Bagian dari tubuh yang dirasakan nyeri
Skala (<i>Scale</i>)	Kekuatan dari intensitas nyeri dengan menunjuk di alat ukur yang tersedia
Waktu (<i>Time</i>)	Waktu timbul nyeri, periode(durasi) nyeri di rasakan
Pengaturan nyeri saat ini	Pengaturan yang dipakai untuk mengendalikan nyeri, keberhasilan
Riwayat mengatasi pengalaman nyeri sebelumnya	Bagaimana cara mengatasi nyeri secara medis dan non medis
Efek nyeri	Perbaikan gaya hidup seperti tidur, aktivitas dan sebagainya
Mengendalikan nyeri tujuannya	Sesuatu yang di harapkan pada intensitas nyeri, sikap toleran , dan pada proses memulihkan kondisi

Sumber: Zakiyah, 2015

BAB 4

Penerapan Hypnobirthing sebagai Teknik Relaksasi untuk Ibu Intranatal

A. Karakteristik Ibu Intranatal

Secara umum wanita pada usia 20-30 tahun secara fisik memiliki organ reproduksi yang masih bagus dan memiliki fungsi organ reproduksi yang optimal untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Tetapi wanita pada usia ini belum mempunyai kesiapan secara psikologis, terutama bagi wanita yang baru pertama kali menghadapi suatu persalinan.

Ada beberapa faktor kesiapan psikologis yang harus diperhatikan dari seorang wanita dalam menjalani proses kehamilan dan persalinan. Kesiapan psikologis yang pertama adalah faktor pengalaman. Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indra yang tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan saat peristiwa yang baru saja

terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat di berikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia (Notoatmojo dalam Saprwati, 2012). Primigravida merupakan ibu yang baru pertama kali melahirkan dan belum memiliki pengalaman tentang nyeri persalinan sehingga tingkat kecemasnya relatif tinggi di bandingkan dengan ibu yang sudah melahirkan (Primisnia dkk, 2013).

Kesiapan psikologi kedua adalah kecemasan. Cemas yang dialami oleh ibu selama persalinan dapat merangsang hipotalamus sebagai pusat sistem limbik yang mengatur emosional. Hipotalamus akan merangsang kerja sistem syaraf simpatis sehingga terjadi vasokonstriksi pada organ dan jaringan uterus. Akibatnya asupan darah ke uterus berkurang, sehingga oksigen dan nutrisi ke jaringan dan sel otot uterus tidak adekuat. Hal ini akan mengganggu metabolisme sel otot uterus, sehingga energi yang di hasilkan berkurang yang menyebabkan gangguan pada kontraksi uterus. Sedangkan reaksi neurofisiologis dari cemas yaitu memacu pengeluaran adrenalin, adrenalin akan memberi pengaruh vasokonstriksi pembuluh darah uterus sehingga vaskulalisasi berkurang yang berakibat berkurangnya kekuatan kontraksi otot rahim yang akan menimbulkan nyeri (Hayati, dkk, 2017).

Kesiapan psikologi ketiga adalah faktor kematangan emosi. Kematangan emosi yaitu kemampuan individu yang tepat pada usianya. Atau dengan kata lain kematangan emosional

adalah suatu proses dimana individu tersebut mampu untuk mengontrol dan mengendalikan emosinya dalam menghadapi berbagai situasi, sehingga dapat mencapai tingkat individu tersebut mampu menguasai emosi dengan lebih baik untuk bisa beradaptasi merespon nyeri dengan tepat untuk suatu persalinan.(Wahdah, Apriliana, 2019).

Pada proses persalinan, bagi seorang primigravida kontraksi uterus lebih kuat karena belum ada pengalaman sebelumnya (Adam dan Umboh, 2015). Kontraksi uterus yang lebih kuat terjadi pada ibu primigravida dikarenakan *effacement* (penipisan) terlebih dahulu dari pada dilatasi servik. Rasa cemas dan takut dapat meningkatkan kerja syaraf simpatik dan ketokolamin (efinefrin dan norefineprin). Hal ini akan menstimulasi reseptor α dan reseptor β . Peningkatan reseptor α menyebabkan seluruh bagian uterus berkontraksi dan menurunkan suplay aliran darah menurun ke uterus. Secara bersama reseptor β meningkat, terjadi peningkatan pada reseptor β akan menurunkan aliran darah dari plasenta ke fetus. Oleh sebab itu sekresi ketokolamin berlebihan akan menurunkan aliran darah dari plasenta fetus dan menurunkan efektivitas uterus. Penurunan efektivitas ke uterus akan menimbulkan persalinan lebih lama dan nyeri hebat (Bolbol-Haghighi & Kazemi, 2016).

Dengan lamanya persalinan bisa membuat seorang ibu semakin cemas dan akan menimbulkan nyeri yang tak bisa di kontrol. Untuk kondisi seperti ini menurut kolkaba

menyebutkan cara mengatasi dan mengelola ketidaknyaman nyeri persalinan dengan dengan membuat struktur taksonomi yang bersumber pada tiga tipe kenyamanan yaitu *reliefe*, *ease*, *transendence*. Kolkaba mengaitkan tiga tipe kenyamanan ini pada pengalaman fisik yaitu, fisik, psikospitual, sosiokultural dan lingkungan (Aligood, 2014). Dengan menggunakan teori ini ketidaknyamanan dari nyeri persalinan dapat di kontrol/didistraksikan.

B. Terapan Murrotal pada Ibu Intranatal

Murrotal adalah salah satu jenis *audiogelsia*, *audioanagelsia* adalah terapi yang dapat meringgankan rasa sakit karena dapat mengalihkan rangsang nyeri melalui suara. Lantuan suara yang diperdengarkan dengan beat antara 60-80 bpm yang sesuai dengan irama nadi manusia (Liu, Chang, Chen, 2010). Cara *audioanalgesia* berkerja menstimulasi gelombang delta yang menyebabkan pendengar dalam keadaan tenang, tentram, dan nyaman sehingga *hypofise* dan *hypotalamus* mengeluarkan β *endorphin* sebagai analgesik alamiah, Jadi dengan memberikan intervensi murrotal pada ibu bersalin dengan cara mendengarkan lantunan ayat-ayat suci al-quran dengan irama yang indah dapat membantu ibu untuk mengalihkan rasa nyeri persalinan (Ananonim, 2014, dikutip Alyesi, Arifin, 2017).

Cara kerja alunan ayat suci Al-Quran melalui murrotal dimulai pada dengan frekuensi bunyi antara 60-80 desibel, melalui serat syaraf dan *ganglion spiralis corti* memasuki

nukleus koklearis dorsalis dan ventralis yang terletak dibagian medulla atas, disini semua serat bersinaps, dan neuron tingkat dua bejalan terutama kesisi berlawanan dari batang otak dan berakhir di *nukleus olivarius superior*. Beberapa serat tingkat kedua juga bejalan ke nukleus olivarius superior pada sisi yang sama dari *nukleus olivarius superior*, jaras pendengaran nerjalan keatas melalui *nukleus leminiskus*,tetapi sebagian besar melewati nukleus ini dan bejalan terus ke *kolikulus inferior* tempat semua atau hampir semua serat pendengaran bersinaps. Dari sini jaras bejalan ke *nukleus genikulutum medial*, tempat semua serat betul-betul bersinaps .akhirnya jaras berlanjut melalui radiasioauditorius ke kortek auditorik dan kortek asosiasi auditorius (Guyton 2014).

Korteks auditorius disini yang bertanggung jawab untuk menganalisa suara yang kompleks. Ingatan yang pendek dan perbandingan nada diterima oleh asosiasi korteks temporalis parietal, oksipital diteruskan ke gabungan korteks prefrontal dan terakhir pada korteks asosisasi limbik lalu menstimulasi *amigdala* di bagian sistem limbik pusat yang mempengaruhi emosi dan prilaku manusia dan terakhir tersimpan di hipocampus. Ingatan tersebut akan secara sadar atau tidak akan terpanggil bila mendapat stimulasi (Sherwood, 2012). Sedangkan di bagian otak lain yaitu pada bagian hipotalamus berkerja menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon pereda stress yaitu hormon *endorfiin*, serotonin dan noradrenalin. Ketiga hormon ini berkerja sebagai neuromodulator untuk

menghambat kerja neurotransmitter yaitu syaraf simpatik, syaraf simpatik dihambat kerja oleh syaraf parasimpatik sehingga rasa sensitif nyeri dapat berkurang, dan nyeri dapat didistraksikan/dialihkan.

Murrotal pun berpengaruh pada bagian tubuh lainnya, adapun pengaruh yang terjadi berupa adanya perubahan arus listrik yang terjadi di otot, perubahan daya tangkap kulit terhadap konduksi listrik, perubahan sirkulasi darah, perubahan detak jantung, dan kadar darah pada kulit. Perubahan tersebut menunjukkan adanya relaksasi atau penurunan urat syaraf reflektif yang mengakibatkan terjadinya vasodilatasi dan penambahan oksigen dalam tubuh dengan menurunkan denyut jantung. Kemajuan teknologi pula telah mendeteksi secara akurat bahwa mendengarkan Al-Qur'an dapat merelaksasi syaraf relaktif, memfungsikan organ tubuh, serta memberikan aura positif pada tubuh manusia. Bacaan Al-Qur'an berefek pada sel-sel dan dapat mengembalikan keseimbangan ibu yang sedang mengalami nyeri persalinan.

Al-Qur'an adalah terapi yang memperdengarkan alunan bacaan Al-Qur'an kepada responden, untuk membantu mengalihkan pikirannya dari rasa nyeri yang sedang dirasakannya. Murrotal Al-Qur'an dengan keteratutan bacaannya yang benar juga merupakan sebuah irama merdu yang mampu mendatangkan ketenangan bagi orang yang mendengarkannya. Pada saat proses persalinan adalah suatu kondisi dimana seorang ibu membutuhkan

banyak suport dan sugesti, termasuk realitas kesadaran terhadap adanya tuhan yang maha esa. Intervensi murrotal dapat membantu ibu bersalin mengalihkan rasa nyeri dan meningkatkan totalitas kepasrahan kepada Allah SWT. Dalam keadaan ini menyebabkan otak berada pada gelombang alpha, yang merupakan keadaan ernergi otak pada frekuensi 8-12 hz. Gelombang otak ini merespon menyingkirkan stress dan kecemasan sehingga ibu bersalin menjadi lebih rileks dan tenang dalam menghadapi nyeri persalinan yang dirasakannya dapat dialihkan.

Murrotal yang diperdengarkan adalah lantunan surat Ar-Rahman dan Maryam. Penggunaan ayat suci Al-Qur'an dari surat Ar- Rahman dan Surat Maryam dapat menstimulasi gelombang delta yang menyebabkan pendengar dalam keadaan tenang, tentram nyaman. Teknik religius ini menggabungkan relaksasi dengan faktor keyakinan spiritual yang membuat jiwa tenang sehingga dapat menciptakan kekuatan dari dalam yang membantu seseorang rileks yang begitu dalam, Al-Qur'an yang mempunyai tempo lambat, teratur dan lembut serta faktor keyakinan di harapkan dengan mendengar Murrotal menimbulkan relaksasi (Wahida,dkk, 2015). Selain itu intervensi yang menggunakan murrotal ini sangat mudah dan murah karena bisa didengarkan dengan berbagai media yang menimbulkan bunyi.dan sangat cocok dengan kebiasaan masyarakat serang yang lebih agamis. Intervensi ini selain dapat meningkatkan ketenangan sehingga timbul relaksasi, serta dengan terapi murrotal dapat meningkatkan

keimanan dan keyakinan kita sebagai umat muslim bahwa kita hanya dengan bantuan Allah swt kita dapatkan kekuatan dan kemampuan untuk berjihad. Karena melahirkan adalah jihad untuk seorang perempuan.

C. Terapan Hypnobirthing pada Ibu Intranatal

Relaksasi *hypnobirthing* membuat ibu merasa rileks dan tenang pada saat timbul kontraksi yang semakin lama makin kuat. Relaksasi *hypnobirthing* terdiri dari relaksasi otot, relaksasi pernafasan dan relaksasi pikiran. Relaksasi otot bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan melenturkan otot-otot badan. Sedangkan relaksasi pernapafasan bertujuan untuk mencegah hiperventilasi dan menambah masuknya oksigen kedalam sel-sel organ tubuh pada saat inpartu. Terakhir yaitu relaksasi pikiran yang digunakan untuk memasukan sugesti positif kedalam bawah sadar ibu. Sugesti/informasi tersebut terprogram di otak ibu sehingga ibu merasa tenang, ibu akan merasa damai dan tidak mudah emosi dan akan lebih antusias menyambut kelahiran bayinya (Nursalam.Dkk, 2008).

Program *hypnobirthing* ini pula mengajarkan kepada ibu untuk menyatu dengan gerak dan ritme tubuh yang alami saat menjalani proses melahirkan. Membiarkan tubuh dan pikiran berkerja serta meyakini bahwa tubuh mampu berfungsi sebagaimana seharusnya sehingga rasa sakit itu dapat dialihkan/dikontrol. Dengan demikian rekaman yang terpatrit dalam pikiran bawah sadar bahwa persalinan itu menyakitkan bisa dihapus dan berganti dengan keyakinan

bahwa persalinan berlangsung mudah, lancar tanpa rasa sakit. Rekaman yang terpatri tersebut dimulai dari gabungan korteks temporo-parietal-oksipital (mengumpul mengintegrasikan sensasi somatik, pendengaran dan penglihatan untuk memproyeksikan memproses informasi yang lebih kompleks). Stimulus tersebut diteruskan kedalam gabungan korteks prefrontal (sebagai pengambilan keputusan untuk mempersiapkan pergerakan dan menginformasikan dalam korteks motorik, terhadap berbagai respon yang telah di programkan). Setelah itu diteruskan dalam korteks limbik (berkaitan dengan motivasi, emosi dan berperan besar dalam memori). Daerah-daerah asosiasi korteks saling berkaitan melalui berkas-berkas serabut di dalam substansia alba serebrum. Secara kolektif daerah asosiasi menintegrasikan beragam informasi untuk tindakan yang telah di program/terekam (Sherwood, 2016).

Apabila rekaman tersebut terpancang, maka akan mengaktifkan mekanisme gate oleh pengiriman impuls ke arah bawah melalui *spinal column* untuk menutup *gate* pada substansi gelatinosa melakukan blok agar persepsi nyeri tidak sampai ke otak, sehingga nyeri dapat di distraksikan. Sedangkan di bagian otak lain yaitu pada bagian hipotalamus berkerja menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon pereda stress yaitu hormon *endorfin*, serotonin dan noradrenalin. Ketiga hormon ini berkerja sebagai neuromodulator untuk menghambat kerja neurotransmitter yaitu syaraf simpatik, syaraf simpatik di hambat kerja oleh syaraf parasimpatik sehingga rasa

sensitif nyeri dapat berkurang, dan nyeri dapat didistraksikan.

Metode *hypnobirthing* dapat memberikan dukungan mental yang berdampak positif bagi keadaan psikis saat proses persalinan yang membutuhkan kondisi yang rileks dan nyaman. Saat kondisi rileks dan tenang, alam bawah sadar ibu akan mengatur keselarasan tubuh dan menghasilkan anastesi atau pembiusan yang alami pada ibu, yaitu hormon *endorfin* (Astuti, Novianti, 2015). Teknik *hypnobirthing* ini sangat efektif di lakukan di puskesmas Singandaru dan Banten Girang dalam memberikan rasa nyaman pada saat persalinan, tetapi teknik ini memerlukan pembelajaran latihan terlebih dahulu sehingga pada saat persalinan ibu sudah memahami dan siap. Pembelajaran ini harus di tempuh dengan cara latihan dan memprogram ulang pemahaman/pemikiran seorang ibu, melalui dibimbing oleh seorang instruktur *hypnobirthing* yang sudah tersertifikasi. Kendalanya untuk saat ini wilayah kota serang belum ada kelas untuk belajar *hypnobirthing*. Untuk kelas *hypnobirthing* saat ini hanya ada di daerah jakarta dan klinik Masita di daerah Cilegon hanya melayani pada saat persalinan tidak melayani untuk kelas *hypnobirthing*.

D. Integrasi Murrotal dan Hypnobirthing dalam Mengurangi Nyeri Melahirkan Pada Ibu Intranatal

Integrasi antara musik murrotal dan hypnobirthing akan memberikan kenyamanan pada ibu bersalin sehingga ibu dapat memdistraksikan/mengontrol nyeribila di bandingkan dengan intervensi ini di berikan secara terpisah. Seperti kata Marie Morgan seorang *hynoterapist* asal Amerika dan yang menciptakan *hypnobirthing* menurut Morgan (2007) dikutip Kuswandi 2020, mengatakan dengan bantuan *self hypnosis* seorang wanita dapat mempersiapkan tubuhnya sendiri untuk berada dalam posisi yang rileks dimana otot tubuh dapat berkerja sesuai dengan apa yang diinginkan selama proses persalinan.

Menurut Kuswandy (2020), tubuh dan pikiran diciptakan dari kumpulan pengalaman lewat indra penglihatan, indra pendengaran, perasaan, pengecapan dan penciuman yang tererekam dalam bawar sadar seorang manusia. *Hypnobirthing* adalah ilmu pengetahuan keterampilan (*science and Art*) untuk memprogram ulang rekaman rasa sakit yang sudah terekam dibawah sadar menjadi nyaman, alami, lancar dan minim trauma. Teori pengontrol nyeri dapat membantu menjelaskan cara kerja hipnosis dan musik. Menurut teori ini, sensasi nyeri akan berjalan sepanjang jalur saraf sensorik ke otak. Namun hanya sejumlah pesan sensasi dan pesan tertentu yang dapat berjalan di jalur ini pada satu waktu yang sama. Dengan teknik pengalih perhatian seperti musik, gambar dan titik vokal, akan mengurangi atau memblokir sepenuhnya

kapasitas jalur syaraf untuk menghantarkan rasa nyeri. Pengalih ini diperkirakan bekerja dengan menutup gerbang hipotek di medulla spinalis sehingga mencegah sinyal untuk mencapai otak. Oleh karena itu persepsi nyeri berkurang. Selain itu ketika wanita yang sedang persalinan melakukan suatu aktivitas neuromuskular dan motorik, aktivitas di medula spinalis itu akan semakin memodifikasi penghantar nyeri. Aktivitas kognitif yang memerlukan konsentrasi pada pernafasan dan relaksasi memerlukan aktivitas korteks yang selektif dan terarah yang menutup mekanisme pengalih nyeri (Lowdermilk, 2013).

Korteks serebrum yang di maksud adalah gabungan korteks temporo- parietal-oksipital (mengumpul mengintegrasikan sensasi somatik, pendengaran dan penglihatan untuk memproyeksikan memproses informasi yang lebih kompleks). Stimulus tersebut diteruskan kedalam gabungan korteks prefrontal (sebagai pengambilan keputusan untuk mempersiapkan pergerakan dan menginformasikan dalam korteks motorik, terhadap berbagai respon yang telah di programkan) setelah itu di teruskan dalam kortek limbik (berkaitan dengan motivasi, emosi dan berperan besar dalam memori). Daerah-daerah asosiasi korteks saling berkaitan melalui berkas-berkas serabut di dalam substansia alba serebrum. Secara kolektif daerah asosiasi mengintegrasikan seragam informasi untuk tindakan yang telah direkam/diprogramkan (Sherwood, 2016).

Bila rekaman tersebut terpanggil akan mengaktifkan mekanisme gate oleh pengiriman impuls ke arah bawah melalui *spinal column* untuk menutup *gate* pada substansi gelatinosa melakukan blok agar persepsi nyeri tidak sampai ke otak, sehingga menghasilkan persepsi positif dan peningkatan relaksasi. Sehingga secara tidak langsung menjaga keseimbangan homeostatis tubuh melalui *HPA Axis* (sistem neuroendokrin hipotalamus yang mengatur reaksi stress), untuk menghasilkan *Corticotropin Releasing Faktor* (CRF) yang berfungsi merangsang kelenjar pituitari untuk menurunkan produksi hormon ACTH(*Adeno Cortico Tropin Hormone*) menstimulasi produksi endorfin khususnya β *endorfin*, serotonin dan noradrenalin. Ketiga hormon ini bekerja sebagai neuromodulator untuk menghambat kerja neurotransmiter yaitu syaraf simpatik, syaraf simpatik dihambat kerja oleh syaraf parasimpatik, kemudian menurunkan produksi kortisol dan hormon-hormon stress. Sehingga rasa sensitif nyeri dapat berkurang dan nyeri dapat didistraksikan (Rantiyana, 2017).

Cara kerja pada bagian otak tersebut dapat dijelaskan oleh penelitian yang berjudul *hypnotic analgesia reduces brain respons to painseen in others* mengenai *hypnoanalgesia* mengatakan bahwa *hipnotis* selain dapat menurunkan nyeri tetapi dapat menghapus respon terkait empati terhadap nyeri yang terlihat pada orang lain. Yang terlihat pada perubahan yang terjadi pada amigdala kanan dengan skor *P value* 0.019 berdasarkan efek puncak utama pada thalamus yang berasal dari kortek prefrontal dan

kemungkinan prosedur *hipnotis* dapat memodulasi proses emosional dan sosial yang tinggi.(Braboszcz, dkk, 2017).

Sedangkan Murrotal adalah terapi musik religi yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas kesadaran seseorang terhadap tuhan, baik yang mengetahui arti Al-Qur'an atau tidak. Kesadaran ini akan menyebabkan totalitas kepasrahan kepada Allah SWT, dalam keadaan ini otak berada pada gelombang alpha, merupakan gelombang otak pada frekuensi 8-12 hz. Hal ini merupakan energi otak yang optimal dan dapat menurunkan dan menyingkirkan stress. Dalam keadaan tenang, otak dapat berpikir jernih dan dapat melakukan perenungan tentang adanya tuhan. Dari sini akan terbentuk koping atau harapan positif. Merenungkan firman Allah SWT melalui suara sangat mempengaruhi medan magnetik dari molekul air dan diketahui molekul-molekul di pengaruhi nada-nada tertentu dan menjadikannya lebih teratur. Sedangkan di ketahui bahwa 70% tubuh manusia terdiri dari air sehingga suara yang didengarkan dapat mempengaruhi keteraturan molekul air dalam sel-sel dan getaranya pada penurunan intensitas nyeri pada persalinan.

Pengunaan salah satu surat yaitu Al-Quran yang salah satunya adalah surat Ar-Rahman yang memiliki 5 keutamaan yang salah satunya agar kita mensyukuri nikmat dari allah dengan pengulangan ayat-ayat sucinya, maka akan mendapat ridha dari allah, sehingga kita akan selalu memiliki sifat yang penuh kasih sayang pada allah dan

mahkluknya (Mustinda, 2019). Memiliki sifat yang penuh kasih sayang ini akan menimbulkan ketenangan dan kedamaian untuk seorang wanita. Dengan hati yang damai dan jiwa yang tenang akan meningkatkan produksi hormon *endorphin* dalam tubuh. Yang kita ketahui *endorphin* adalah salah satu analgesia alami yang berada dalam tubuh. Menurut Lie, 2012 mengatakan peptida opioid endogen dan reseptornya yang mengalami modulasi sebagai respon terhadap nyeri ada tiga kelas peptida opioid endogen yaitu (*enkephalins*, *dynorphin* dan *endorphins*), pada *endorphin* ada tiga macam yang berperan yaitu *endorphin* α , *endorphin* γ , dan *endorphin* β . Dari ketiga macam *endorphin* tersebut yang paling sensitif dan banyak berperan dalam nyeri yaitu *endorphin* β , karena jauh lebih besar jalur peptidanya, sehingga *endorphin* tidak selalu membutuhkan glikosilasi untuk mencapai hasil efektif laju lompatan membran untuk menghasilkan transportasi yang efektif.

Beta *endorphin* secara primer disintesis dan disimpan di kelenjar hipofise anterior dari protein prekursor proopiomelanokortin (POMC) menuju sistem sirkulasi. Produksi opiat diatur oleh transkripsi gen dari sintesis prekursor peptida. Dikenal ada tiga prekursor peptida proopiomelanokortin (POMC) sumber *endorphin*; proenkephalin dan β Sumber beberapa enkephalin dan dynorphin-dynorphins. POMC adalah prekursor peptida yang pertama diidentifikasi. Banyak terdapat di lobus anterior dan hipofise intermedial dan area lain di otak, pada sistem syaraf pusat, dan diberbagai organ lain seperti

gonad, plasenta, taktus intestinal, paru-paru. Namun yang tertinggi pada hipofise. POMC dipecah menjadi dua fragmen, fragmen ACTH intermediete dan β lipotropin. Lipotropin tidak mempunyai aktifitas opoid, kemudian dipecah menjadi β -melanocyte-stimulating hormone (β MSH), enkephalin; dan α , γ , β endorphins aktif sebagai morfin, dengan β endorphins. 5-10 kali lebih poten. Pada kelenjar hipofise dewasa, hasil utama adalah ACTH dan β endorphin. Pada otak, peptida terbanyak adalah opiat dengan sedikit ACTH. Pada hipotalamus adalah β endorfin dan α MSH pada nukleus arkuatus dan nukleus ventromedial. Sistem opiat pada hipofise berperan untuk sekresi ke dalam sirkulasi, sedangkan sistem opiat pada hipotalamus adalah untuk penyebaran pada akson untuk mengatur berbagai daerah dalam otak dan hipofise.

Beta *endorfin* dianggap sebagai neuromodulator. Beta endorfin mempengaruhi beberapa fungsi di hipotalamus, termasuk pengaturan reproduksi, pengaturan suhu, kardiovaskular dan fungsi pernapasan. Juga sebagai fungsi ekstra hipotalamik seperti persepsi nyeri dan *mood* (Sidemen, Aiesti, 2016). Selain menggunakan surat Ar-Rahman penelitian ini pun memakai surat Maryam, menurut Surat Maryam adalah surat ke-19 dalam Alquran, yang terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Maryam adalah salah satu surat yang sering dibaca ibu hamil karena dipercaya memiliki berbagai manfaat dan keutamaan. Selain nutrisi dan perhatian, doa yang baik juga penting dibacakan untuk mencapai tujuan

mulia dari kehamilan. Dinamai surat Maryam karena tersurat kisah Maryam yang merupakan ibu dari nabi Isa yang dapat melahirkan putranya tanpa pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Perjuangan Maryam dalam menjalani masa kehamilan tanpa bantuan seorangpun, cacian masyarakat sekitarnya setelah kelahiran putranya dan keteguhan imannya memberikan banyak pelajaran yang luar biasa. wanita hamil dan melahirkan memiliki kondisi psikologis yang lebih labil karena ketidakseimbangan hormon yang dialaminya. Walaupun terkadang ibu hamil berada dalam kondisi yang lemah tetapi dia tetap mampu membaca atau mendengarkan Alquran terutama surat Maryam, supaya ibu hamil dan melahirkan memiliki kondisi emosional yang lebih stabil.

Bacaan ayat-ayat Al-Quran dapat menenangkan hati, sebagaimana diterangkan dalam surat ar-rad ayat 28, yaitu:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Yang artinya:“(yaitu) Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram”(QsA-Ra’d/13:28).

Ayat diatas di perkuat oleh hadits bahwa Rasulullah SAW

عَلَيْهِمْ وَنَزَّلَتْ وَغَشِيَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ حَقَّتْهُمْ إِلَّا وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ يَذْكُرُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُ لَا
عِنْدَهُ فِيمَنْ اللَّهُ وَذَكَرَهُمُ السَّكِينَةُ

Bersabda:

Artinya : “Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah (Masjid) Allah, mereka membaca Al- Quran dan memperlajarinya kecuali turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi dengan rahmat,malaikat menaungi mereka dengan Allah menyebut-nyebut mereka pada mahluk yang ada di sisinya” (HR. Muslim, no 2700)

Perpaduan *audioanalgesia* dan *hypnoanalgesia* melalui gabungan intervensi Murrotal dan *hypnobirthing* adalah perpaduan yang selaras. Terbukti dengan nilai intensitas nyeri selisihnya lumayan tinggi di dibandingkan intervensi yang di berikan hanya murrotal saja atau *hypnobirthing* saja di puskesmas Singandaru dan Banten Girang. karena Intervensi gabungan antara murrotal dan *hypnobirthing* membuat responden merasa nyaman untuk melakukan distaksi nyeri. Salah satu dari penyebab nyeri itu sendiri karena adanya iskemia otot uteri karena adanya penurunan aliran darah akibat kontraksi ateri miometrium. Metode *hypnobirthing* membantu memusatkan perhatian berdasarkan pada keyakinan bahwa pereumpuan dapat mengalami persalinan secara lami dengan tenang , nyaman dan percaya diri. Teknik ini mengajarkan ibu untuk lebih rileks, sehingga tubuh dapat berkerja dengan seluruh syaraf secara harmonis.ini *hypnobirthing* berkerja dengan baik di

amigdala dan hipotalamus untuk mengubah respon stress. dengan cara relaksasi pernafasan, relaksasi otot, relaksasi pikiran dan penanaman afimasi positif yang dapat meningkatkan oksigen keseluruh tubuh. karena peningkatan oksigen ini memiliki pengaruh besar dan penurunan otonom stress. Mengisi sel dengan oksigen. Dengan terisinya sel oleh oksigen dapat merileks sel-sel otot dan meningkatkan aliran darah ke uterus maka nyeri dapat didistraksikan/dikontrol (Sariati.Y, DKK, 2016).

Sedangkan murrotal yang memiliki pengaruh dengan memfokus diri mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an melalui merdunya irama murrotal yang dibacakan oleh qori terbaik akan menimbulkan energi positif yang memberikan efek relaksasi dan dapat menenangkan serta membuat orang yang mendengarkannya dapat berimajinasi. Dan dengan berimajinasi seorang ibu dapat membayangkan dirinya dalam lingkungan yang damai, tenang, sehat dekat dengan sang pencipta yang akhirnya nyeri dapat didistraksikan. Perpaduan dua intervensi ini akan membuat responden merasa lebih nyaman, rileks dan aman pada saat proses persalinan, sehingga nyeri dapat responden kontrol/distraksikan. setelah nyeri dapat mendistraksikan/mengontrol, maka akan timbul suatu perasaan yang puas dan bahagia.

Menurut Fahrud, dkk, mengatakan kebahagiaan itu berasal dari 2 dimensi yaitu endogenik dan eksogenik. Dimensi endogenik meliputi biologis, kognitif, person-sub-fakto etika, dan dimensi eksogenik meliputi perilaku, sosial-

budaya, ekonomi, geografis, peristiwa kehidupan dan sub-faktor estetika. Dari dimensi endogenik ini yang paling berpengaruh merupakan indikator biologis dan psikologis, Pengaruh faktor biologis dan kognitif yang positif ini yang akan membuat seorang ibu bahagia dan melahirkan bayi dengan kepribadian/temperamen yang baik dan spiritual intelegensi (SQ) yang tinggi. Selain untuk ibu dan janin, bermanfaat juga bagi suport sistemnya yaitu suami karena mulai terjalin ikatan kasih sayang.

BAB 5

Penutup

Peran Perawat adalah Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diruang bersalin dalam pelaksanaan kenyamanan pada ibu, khususnya ibu pada intranatal kala I. Perawat dapat melibatkan pasien dan keluarga dalam asuhan keperawatan, sehingga tercipta kerjasama yang baik dan rasa tanggung jawab.

Dengan Hadirnya Buku ini di kami menekankan Bahwa:

1. Memberi kenyamanan dan menghilangkan stress kepada ibu ketika akan menghadapi persalinan sehingga ibu dan keluarga dapat menikmati proses persalinan dengan senang dan bahagia
2. menjadikan teknik ini sebagai alternatif terapi untuk mengurangi nyeri persalinan pada kala I dalam memberikan rasa nyaman pada saat bersalin.
3. Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan di bidang ilmu keperawatan terutama keperawatan maternitas tentang pengaruh *hypnobirthing* dan murrotal terhadap intensitas nyeri persalinan

Daftar Pustaka

- Abdurachman & Andhika S. 2008. Murottal Al-Qur'an: ALternatif Terapi Suara Baru. Iniversitas Lampung. Seminar Nasional Sains dan Teknologi-II Universitas Lampung.
- Ardhiyanti.Y, Safitri.L,2015, Pengaruh Teknik Relaksasi Hypnobrithing Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Kala I Persalinan Normal Pada Primipara Di BPM Evi, Jurnal keperawatan maternitas volume 2 no 2.
- Adam, J., & Umboh, J. (2015). Hubungan antara Umur, Parietas dan Pendampingan Suami dengan Intensitas Nyeri persalinan Kala I Fase Aktif Deselarasi di ruang Bersalin RSUD Prof. Dr, H. Aloei Saboe Kota Gorontalo. JIKMU, 406-413.
- Alyesnsi.F,Arifin.H,2018, Pengaruh Terapi Murrotal Al-Qur'an Terhadap Intensitas Nyeri persalinan kala 1 Fase Aktif Bidan Praktik Mandiri (BPM) Ernita Kota pekan Baru 2017, Online jurnal kebidanan, Vol 8 No 1 Oktober2018 P ISSN 2089-7669, eISSn 261-2870.
- Astuti.I, Noviyanti, 2015, Pengaruh Hypnobrithing Terhadap Tingkat Nyeri dan kemajuan persalinan pada ibu bersalin di BPM Kota Cimahi, The Southeast Asian Journal of Midwifery vol. 1 no. 1 Oktober 2015;43-47 p- ISSN;2476-9738.e- ISSN;2476-9720.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Jensen, M. D. & Perry, S. E., 2005. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. 4 ed. Jakarta: EGC.
- Braboszcz. C, dkk,2017, Hypnotic Analgesia Reduces Brain responses to pain seen in others, www.nature.com/scientificreports.
- Bolbol-Haghighi, N., Masoumi, S. Z., & Kazemi, F. (2016). Effect of Massage Therapy on Duration of Labour: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Clinical & Diagnostic Research*, 1-10.

- Chunaeni.S, Dkk,2016, efektivitas terapi Murrotal terhadap penurunan nyeri Bersalin Kala 1 Fase Aktif. Online Rakernas AIPKEMI.
- Czech, I. et al., 2018. Pharmacological and Non-Pharmacological Methods of Labour Pain Relief: Establishment of Effectiveness and Comparison. *International Journal of Environment Research and Public Health*, 15(2792), pp. 1-11.
- Down, T., 2017. Katharine Kolcaba: Teori Kenyamanan. In: M. R. Alligood, ed. *Pakar Teori Keperawatan dan Karya Mereka*, Edisi Indonesia ke-8, oleh
- Achir Yani S. Hamid dan Kusman Ibrahim. Singapore: Elsevier, pp. 187- 202.
- Dhama.K.K.2015. Metodologi Penelitian Keperawatan Panduan Pelaksanaan Dan Menerapkan Hasil Penelitian. CV Trans info media . Jakart; TIM .
- Diana.U, 2016 Gambaran pemberian Auditory Murrotal Terhadap penurunan Rasa Nyeri ibu Inpartu kala I Fase Aktif di rumah bersalin Mattiro baji kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, FK kedokteran dan Ilmu kesehatan universitas islam Negeri Makasar.
- Farhud.D.D, dkk, 2014, Happiness & Health : The Biological factors- Sistematic Riview Article , *Iranian J Publ Health*, vol. 43 no 11, hlm 1468-1477.
- Faridah.BD, Yefrid, Masmura.S, 2017, Pengaruh Murrotal Al-Qur"an Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Ibu Bersalin Kala I Faseaktif Di Ruang Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan, *Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK)* Oktober 2017Volume 1 Nomor 1 P-ISSN :2597-8594,E-ISSN:2580-930x
- Guyton,Hall,2014, Buku ajar Fisiologi kedokteran edisi duabelas. Elsavier; Singapore
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ganji, Z., Shirvani, M. A., Rezaei-Abhari, F. & Danesh, M., 2013. The Effect of Intermitten Local Heat and Cold on Labour Pain and Childbirth Outcome. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 18(4), pp. 298-303

Hariyani, F., Murti, N. N., & Wijayanti, E. (2019). Hubungan Usia, Paritas, Dan Kelas Ibu Hamil Dengan Komplikasi Persalinan Di RSKB Sayang Ibu Balik Papan. *Mahakam Midwifery Journal*, 364-377.

Hartati.S, Budiati.T, 2016, Penerapan Teori Selfcare Orem dan Comfort Kolcaba Pada Ibu Post Partum Seksio Sesarea dengan Tubektomi, [http: ejournal.umm.ac.id/ index.php/ Keperawatan / issue/view](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/Keperawatan/), P-ISSN:2086- 3071.E-ISSN:2443-0900Volume 7. 2 Juli 2016.

Harahap. D, 2009, Pengaruh Teknik Relaksasi Hypnosis Terhadap Tingkat Nyeri Dan Lama Persalinan Ibu Primipara Di RS Ananda, Bekasi, Tesis, Jakarta; Universitas Indonesia

Hayati.F, Dkk, 2017, Perbedaan tingkat kecemasan ibu Bersalin di Puskesmas dengan di Bidan Praktek Mandiri dan Hubungannya dengan lama Persalinan, Online, [https:// jurnal .fk.unand.ac.id](https://jurnal.fk.unand.ac.id) hal 564-570.

Heru. 2008. *Ruqyah Syar'I Berlandasan Kearifan Lokal*. Jakarta: FKUI

IASP, 2017. International Association for Study of Pain-Working Together for Pain Relief. [Online] Available at:<https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698> [Accessed 17 Desember 2019].

Kalsdottir, S. I. et al., 2017. Predictors of Women's Positive Childbirth Pain Experience: Findings from an Icelandic National Study. *Woman and Birth*, 705(7), pp. 1-7.

Karlsdottir, S., Sveinsdottir, H., Olafsdottir, O. & Kristjansdottir, H., 2015. Pregnant women's expectations about pain intensity during childbirth and their attitudes towards pain management: finding from an Icelandic national study. *Sex*

Reprod. Healthc., pp. 211-218.

Kemenkes, 2019. Kemenkes Dorong Pembangunan SDM Era 4.0, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kuswandi.L, 2018. Keajaiban Hypnobrithing, Jakarta; PUSTAKA BUNDA Muhidayati.W ,Et. Al, 2018, effect of Hypnobrithing on the progres sof the latent Phase of labor in primigravida,Issn: 2477-4073. Online,http: // belitungraya.org/BRP/index.php/bnj, Nursing Journal .

Liu.YH,dkk,2010, Effect Of Music Terapi on labour pain and anxiety in Taiwanase First-time Mothers, Journal of Clinical Nursing ,19,1065-1072 doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.03028.x.

Lennon, R., 2018. Pain Managemen in Labour and Childbirth: Going Back to Basic. British Journal of Midwifery, 17 October, 26(10), pp. 637-641.

Lowdermilk, D., Perry, S. & Cashion, K., 2013. Buku Keperawatan Maternitas, Edisi 8-Buku 1. 8 ed. Jakarta: Penerbit Salemba Medika.

Legiati.T,2017, Hypnobirthing Effect On The Level Of Pain In Labor, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Kemas 13(2) 185-190.

Li.Y,Dkk, 2012, opioidglycopeptide analgesics derivedendogenous enkephalins and endorphins , NIH PublicAccess, PMC.

Muhidayati.W ,Et. Al, 2018, effect of Hypnobrithing on the progres sof the latent Phase of labor in primigravida,Issn: 2477-4073. Online,http: // belitungraya.org/BRP/index.php/bnj, Nursing Jounal.

Maryuni, 2020, Hubungan karakteristik Ibu bersalin dengan nyeri persalinan,http://jurnal.stikes-sitihajar.ac.id/index.php/jhsp hal 116- 122,pISSN:2548-3943.

Mardana.p, Aryasa. T, 2017, penilain nyeri, FK Udayana; Denpasar.

Nursalam, 2016, Metodologi Penelitian Ilmu Pendekatan Ilmu Praktis Edisi 4, Jakarta; Salemba Medika.

Natalina.D, 2013, Terapi Musik Bidang keperawatan, Jakarta; Mitra Wacana Media.

Nadhia Elsa. 2015. Pengaruh Terapi Mendengarkan Murottal Al-Qur"an Terhadap Tingkat Kecemasan Anak Presirkumsisi di Rumah Sunat Bintaro. Universitas Hidayatullah Jakarta.

Nisa.W.N,A.H.D,2019,Hubungan Kematangan Emosional dan persn Suami dengan Kesiapan Primigravida Menghadapi Persalinan, Online, <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php.sjkp>, DOI: <http://dx.doi.org/10.34310/jskpv6i2.266>, pISSN 2301-6221;eISSN2502- 5236, Jurnal SMART keperawatan, 2019 6(2) 86-97.

Nursalam,Dkk,2008, Hypnobirthing Meningkatkan Toleransi Nyeri Dan Menurunkan Kecemasan Ibu Inpartu Kala I Fase Aktif, Jurnal Ners Vol 3 No1, hal 54-60.

Nurhayati.Y,DKK,2017, Manfaat latihan Relaksasi Hypnobirthing padaproses persalinan kala I, JPPNI Vol 01/no 03/ Desember 2016- Maret 2017, FK UGM, Jurusan magister keperawatan , Yogyakarta.

Oktra. S.PD, Purnawan. I & Achiriyati, 2016, pengaruh terapi Murrotal Al- Qur"an terhadap Kualitas tidur Lansia Di unit Rehabilitasi Dewanata Cilacap, Jurnal keperawatan Soedirman, Volume 11, No 3 November 2016.

[Online] <https://news.detik.com/berita/d-4694936/surat-ar-rahman-yang-punya-5-keutamaan-bagi-umat-muslim>.

[Online]{<https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-4861914/surat-maryam-kandungan-makna-dan-keutamaannya>.

[Online] <https://dosenpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli>

Philips & Moore,2012, *Birthing Outcomes From An Australian Hypnobirthing Programme*,British journal of midwifery vol 20 no 8 hal 558-564

Rahmawati.A.I, 2018, pengaruh Hypnobirthing dalam menurunkan

kecemasan, Skripsi, Malang, UIN.

Rantiyana.Dkk, 2017, Pengaruh Terapi Murrotal Al- Qur'an terhadap intensitas Nyeri pada pasien Luka Bakar, Jurnal Keperawatan dan Kebidanan Vol 13,no 2 hal 167-177.

Reeder, Martin & Koniak-Griffin, 2012. Keperawatan Maternitas: Kesehatan Wanita, Bayi dan Keluarga.. Alih bahasa Yati Afiyati, dkk. Edisi 18 ed. Jakarta: EGC.

Rahmawati. AF, 2018, Pengalaman pertama Ibu melahirkan Secara Normal didampingi Suami, Skripsi, Program Studi Keperawatan FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rilla. E.V,dkk, 2014, Terapi Murrotal Efektif Menurunkan Tingkat Nyeri dibandingkan terapi musik pada pasien pasca bedah, Jurnal Keperawatan Indonesia volume 17 no 2 2014 hal 74-80, p-ISSN 2354-9203, Bandung; Jawa Barat.

Suwenten.M, 2018, practical Hynotheraphy Guide Book,Solo: Metagraf.

Sariarti. Y, Dkk,2016 pengaruh hypnobirthing terhadap kecemasan bersalin dan lama persalinan dibidan praktek mandiri wilayah kabupaten malang, Jurnal Ilmiah Bidan, Vol I,no 3, Hal 35-44

Suwardi.A.R,Rahayu.D.A, 2019, Terapi Murrotal terhadap penurunan Tingkat Nyeri pada pasien kanker, Jurnal keperawatan jiwa volume 7 no 1, hal 27-31, eISSN 2655-8106,p-ISSN2338-2090,Semarang; Jawa Tengah.

Sherwood, Lauralee. 2019. Fisiologi Manusia:Dari Sel ke Sistem, Ed, 6.Jakarta:EGC.

Siswantinah. 2011. Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Kecemasan Pasien Gagal ginjal Kronik yang Dilakukan Tindakan Hemodialisa di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang.

Sastroasmoro,S& Ismail,S, 2010 dasar- dasar metodologi penelitian klinis edisi 3 Jakarta; Sagung Seto.

Sugiyono,2017, Statistika untuk Penelitian, Bandung; ALFABETA.

Sidemen. IGP,Ariesti.BF,2016, Peran Endorfin dan Manjemen Nyeri, FK UNUD;RSUP SANGLAH

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2016.Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik. Jakarta : DPP PPNI.

Turlina.L, Nurhayati.HS,2017, Pengaruh Terapi Murrotal Al- Qur'an Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif, Stikes Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur.

Wahida.S, Dkk, 2015, Terapi Murrotal Al- Qur'an Ar-Rahman Meningkatkan Kadar β endorphen dan menurunkan Intensitas Nyeri pada ibu bersalin kala I Fase Aktif, Online, Jurnal Kedokteran Brawijaya. Vol.28.no 3 Febuari 2015.

Yessie Aplilia, 2019, Bebas Takut Hamil Dan Melahirkan , jakarta, GM. Yessie Aplilia,2010, Hipnostetri, Jakarta, GM.

Yuminah, 2014, Aplikasi Teori Comfort Colkaba Dalam Asuhan Keperawatan Anak Yang Mengalami Nyeri Di Ruang BCH RSUPN DR Cipto Mangunkusumo, Karya Ilmiah, Jakarta,;Universitas Indonesia

Zakariyati,DKK,2017, efektifitas terapi Murrotal Al-Qur'an terhadap perubahan kadar Sitokin IL-6 Pada Pasien Tuberkolosis Paru, Journal Of Islamic Nursing ,Volume 2 nomor 2, Universitas Hassanudin:Makasar

Glosarium

A

Anamnesa: Proses pengumpulan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien melalui wawancara dengan pasien atau keluarga pasien. Dalam konteks medis, anamnesa dilakukan untuk memahami keluhan, gejala, riwayat penyakit, dan faktor risiko yang dapat membantu dalam proses diagnosis dan perencanaan pengobatan.

Android: Sistem operasi perangkat mobile

Antenatal Care: Perawatan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan

B

BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah): Kondisi ketika bayi yang baru lahir memiliki berat badan yang lebih rendah dari normal, yaitu kurang dari 2.500 gram, terlepas dari usia kehamilannya.

C

CPD (Cephalo Pelvic Disproportion): adalah kondisi yang terjadi ketika ukuran kepala bayi terlalu besar atau panggul ibu terlalu sempit untuk memungkinkan kelahiran normal.

D

Diagnosis: proses identifikasi penyakit atau kondisi medis berdasarkan gejala, tanda-tanda klinis, hasil pemeriksaan fisik, serta hasil laboratorium dan diagnostik lainnya.

E

Efisiensi: Tingkat kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Eklampsia : Kondisi medis yang berbahaya selama kehamilan yang ditandai dengan kejang-kejang yang terjadi setelah preeklampsia, yaitu kondisi hipertensi (tekanan darah tinggi) yang disertai dengan adanya protein dalam urine.

Profil Penulis



Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.

Lahir di Bandung, 21 November 1980. Pendidikan Sarjana Keperawatan di Stikes Bina Permata Medika tahun 2014, Pendidikan Ners Di Stikes Faletahan Tahun 2018, Pendidikan Magister Keperawatan Khusus Maternitas Di Universitas Muhammdiyah Jakarta tahun 2020. Saat

ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Kesehatan Reproduksi, Keperawatan Dasar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hesti_321@untirta.ac.id

Motto: "enjoy your life because too much surprise in the live "

Buku ini membahas intervensi non-farmakologis dalam mengurangi nyeri persalinan, yaitu melalui penerapan terapi murrotal dan hypnobirthing. Keduanya merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek fisiologis, psikologis, dan spiritual. Dalam praktiknya, kedua teknik ini mampu memberikan efek relaksasi yang mendalam dan menstimulasi produksi hormon endorfin sebagai analgesik alami dalam tubuh.

Penjelasan dalam buku ini didasarkan pada kajian ilmiah tentang mekanisme kerja otak, sistem saraf, serta sistem hormon dalam merespons rasa nyeri dan stres. Hypnobirthing bekerja melalui sugesti positif dan teknik relaksasi untuk menenangkan pikiran ibu, sementara murrotal berperan sebagai terapi audio spiritual yang mampu memberikan ketenangan jiwa melalui lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kombinasi keduanya terbukti mampu menurunkan intensitas nyeri dan mempercepat proses persalinan secara lebih nyaman.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa keperawatan, bidan, praktisi kesehatan, maupun ibu hamil yang ingin menjalani persalinan dengan pendekatan alami, tenang, dan penuh kesadaran spiritual. Disajikan dengan bahasa yang lugas namun tetap ilmiah, buku ini menjadi referensi tepat untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan maternal yang humanis dan berbasis nilai-nilai keislaman.

Buku ini membahas intervensi non-farmakologis dalam mengurangi nyeri persalinan, yaitu melalui penerapan terapi murrotal dan hypnobirthing. Keduanya merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek fisiologis, psikologis, dan spiritual. Dalam praktiknya, kedua teknik ini mampu memberikan efek relaksasi yang mendalam dan menstimulasi produksi hormon endorfin sebagai analgesik alami dalam tubuh.

Penjelasan dalam buku ini didasarkan pada kajian ilmiah tentang mekanisme kerja otak, sistem saraf, serta sistem hormon dalam merespons rasa nyeri dan stres.

Hypnobirthing bekerja melalui sugesti positif dan teknik relaksasi untuk menenangkan pikiran ibu, sementara murrotal berperan sebagai terapi audio spiritual yang mampu memberikan ketenangan jiwa melalui lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kombinasi keduanya terbukti mampu menurunkan intensitas nyeri dan mempercepat proses persalinan secara lebih nyaman.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa keperawatan, bidan, praktisi kesehatan, maupun ibu hamil yang ingin menjalani persalinan dengan pendekatan alami, tenang, dan penuh kesadaran spiritual. Disajikan dengan bahasa yang lugas namun tetap ilmiah, buku ini menjadi referensi tepat untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan maternal yang humanis dan berbasis nilai-nilai keislaman.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

